

Conceptos generales de Cuidados Paliativos

Material lectura módulo 1



Instituto Nacional
del Cáncer



Ministerio de Salud
Argentina

Autoras: Tedeschi Valeria, Vazquez Ailén, Bunge Sofía, Peirano Gabriela

CONCEPTOS GENERALES: CUIDADOS Y ATENCIÓN PALIATIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (ENT)

“Daremos preferencia a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud y trataremos de atender las necesidades sanitarias de todas las personas a lo largo del curso de la vida mediante servicios de promoción, prevención, curación, rehabilitación, y atención paliativa”¹.

Definición de Cuidados Paliativos

Los Cuidados Paliativos (CP) son definidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “el enfoque que mejora la calidad de vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento, por medio de la identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales”².

Años más tarde, la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos (International Association for Hospice and Palliative Care: IAHPC), redefinió el concepto, basándose en un consenso que se enfoca en el alivio del sufrimiento grave relacionado con la salud:

Los CP son la asistencia activa, holística, de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud debido a una enfermedad grave, y especialmente de quienes están cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores³.

.

Cuidados Paliativos: Una necesidad creciente

Se estima que, en el mundo, cada año, 56,8 millones de personas, incluyendo 25,7 millones en su último año de vida requieren cuidados paliativos y el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo-mediano. Lamentablemente, en la actualidad a nivel mundial, **solo reciben asistencia paliativa un 14% de las personas que la necesitan**⁴⁻⁵.

Una amplia gama de enfermedades requiere cuidados paliativos. La mayoría de los adultos que los necesitan padecen enfermedades crónicas tales como **enfermedades cardiovasculares (38,5%), cáncer (34%), enfermedades respiratorias crónicas (10,3%), sida (5,7%) y diabetes (4,6%)**⁶.

Muchas otras afecciones pueden requerir asistencia paliativa, por ejemplo: insuficiencia renal, enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoide, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas y tuberculosis resistente a los medicamentos⁷⁻⁸.

Las ENT, producen 41 millones de muertes cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. Cada año mueren por ENT 15 millones de personas entre 30 y 69 años de edad, más del 85% de estas muertes “prematuras” ocurren en países de ingresos bajos y medianos⁹.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9 millones), las enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables

de más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT y son la principal causa de muerte y discapacidad en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe¹⁰⁻¹¹.

Argentina, como muchos países, está viviendo una transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas. Las principales causas de muerte en el país son las enfermedades cardiovasculares (35% del total de muertes), el cáncer (21%), las enfermedades respiratorias (7%), las lesiones (7%) y la diabetes (3%)¹².

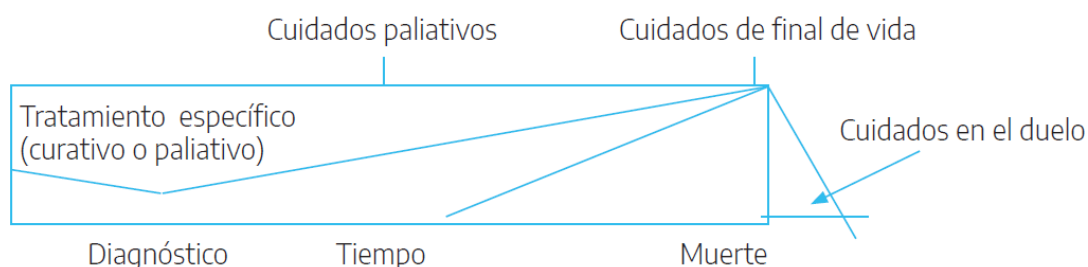
El control de las ENT requiere un fortalecimiento de los sistemas de integración del primer, segundo y tercer nivel de atención. Un control apropiado también debe abarcar la prevención, el tamizaje y la detección temprana, así como el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación y el **cuidado paliativo**. La importancia del cuidado paliativo como componente esencial del cuidado está siendo reconocida por los prestadores de salud, los representantes de los gobiernos y los legisladores.

En julio de 2022 se promulgó la **Ley Nacional de Cuidados Paliativos** (número 27.678), que tiene como objetivo garantizar prestaciones integrales en sus distintas modalidades, en el ámbito público, privado y de la seguridad social, a las personas que sufren enfermedades amenazantes para su vida y brindar acompañamiento a su entorno familiar. Esta ley se encuentra en vías de reglamentación.

Los **principios** en los que se apoya el CP son:

Unidad terapéutica: paciente y familia.
Atención y acompañamiento al paciente y familia basado en sus necesidades .
Atención integral, accesible y equitativa .
Continuidad de la atención y coordinación de niveles asistenciales.
Comunicación abierta y honesta.
Reflexión ética y participación del paciente y familia en la toma de decisiones.
Competencia y desarrollo profesional continuados para responder adecuadamente a las necesidades del paciente y familia.
Trabajo en equipo interdisciplinar .
Actuaciones terapéuticas basadas en las mejores evidencias disponibles.

Figura 1. Modelo de Atención Oncológica Integral según el *National Cancer Institute*¹³



Tal como muestra la figura 1, los CP deberían comenzar en las fases tempranas del diagnóstico de una enfermedad que amenaza la vida, simultáneamente con los tratamientos curativos.

De la misma forma, incluso en las fases finales de la enfermedad, en las que el tratamiento es predominante paliativo, puede existir un espacio para el intento destinado a las medidas de tratamiento específico de la enfermedad. Así, la transición de los tratamientos curativos a los paliativos debería ser gradual, y basarse en las **necesidades individuales** de la persona, más que en un plazo concreto de supervivencia esperada.

Transiciones conceptuales

Las transiciones conceptuales más relevantes en la atención paliativa al inicio del siglo XXI son¹⁴:

DE	A
Enfermedad terminal	Enfermedad crónica avanzada evolutiva
Pronóstico de días / semanas / 6 meses	Pronóstico de vida limitado
Evolución progresiva	Evolución progresiva con crisis
Cáncer	Todas las patologías crónicas evolutivas
Mortalidad	Prevalencia
Dicotomía curativa versus paliativa	Atención sincrónica, compartida y combinada
Intervención rígida	Intervención flexible
Tratamiento específico vs paliativo	Tratamiento específico que no contraindica el paliativo
Pronóstico como ítem central	Complejidad como criterio de intervención de los servicios
Respuesta pasiva a crisis	Actitud proactiva, preventiva y gestión de caso
Rol pasivo del enfermo	Autonomía del paciente, planificación de decisiones anticipadas
Cuidados paliativos	Atención paliativa
Servicios específicos	Medidas de mejora en todos los servicios del sistema de salud
Atención fragmentada	Atención coordinada e integrada
Paciente institucionalizado	Paciente en la comunidad
Paciente paliativo	Paciente con necesidades de atención paliativa

En las transiciones vemos reflejados los desafíos a los que hacer frente para una mejor atención de las personas con enfermedades crónicas avanzadas, desde el punto de vista sanitario, social y cultural, que vienen determinados por elementos actuales de la práctica asistencial: personas con condiciones de cronicidad avanzada sin identificar, fragmentación del sistema sanitario, cuidados paliativos que intervienen en fases avanzadas de la enfermedad (se derivan a los paciente o solo se hace una mirada desde la visión paliativa en el momento de agonía o de final de vida, últimos 3 meses), mayoritariamente en pacientes oncológicos, profesionales con insuficiente formación en habilidades de comunicación y planificación de decisiones anticipadas.

Los cuidados paliativos modernos se iniciaron en el St. Christopher's Hospice en la década de 1960. Introdujeron conceptos como el carácter multidimensional de las necesidades de los enfermos, el paradigma del dolor total, la unidad de atención paciente-familia, y desarrollar una concepción global de la terapéutica, practicada por un equipo interdisciplinario, fundamentalmente en los hospicios. En estos comienzos los cuidados paliativos se confinaban a las situaciones de enfermedad por cáncer con un pronóstico de vida limitado y a intervenciones de carácter disociado y rígido. Actualmente se ha evolucionado a un modelo aplicable a cualquier enfermedad crónica evolutiva en toda su trayectoria, basado en las necesidades y la complejidad de pacientes y familias, en comunicación permanente con el equipo de salud del PNA y especialistas. Este último modelo se caracteriza por ser flexible y cooperativo, con intervenciones compartidas, en el que el pronóstico de vida más largo o la indicación de tratamiento específico no son barreras para la intervención paliativa.

Criterios de enfermedad avanzada

Existen **criterios globales y específicos de enfermedad avanzada** y diversos instrumentos permiten identificarlas, con parámetros de carácter clínico general (deterioro funcional, pérdida de peso, disminución de la albúmina, comorbilidad), asociados a algunos específicos de cada enfermedad, como son:

- el Instrumento **NECPAL (versión 4)**¹⁵

Utilizado para identificar precozmente a personas con necesidades de atención paliativa y pronóstico de vida limitado en servicios de salud y sociales, con el objetivo de mejorar activamente su atención, instaurando de manera gradual y progresiva una “visión” o “enfoque” paliativos, con énfasis en la mejora de calidad de vida.

(Ver en Anexo Capítulo 1, el Anexo 1)

- el **SPICT** (Instrumento Indicador de CP y Soporte)¹⁶

Es un instrumento que se utiliza para ayudar a identificar a las personas con sufrimiento grave. La evaluación tiene como objetivo detectar necesidades paliativas no cubiertas y elaborar un plan de cuidados.

(Ver en Anexo Capítulo 1 el Anexo 2)

Además, se han definido las **trayectorias clínicas paradigmáticas** para algunos tipos de enfermedades, tales como las insuficiencias orgánicas (renal, cardíaca, respiratoria, hepática), las enfermedades neurológicas progresivas, los síndromes relacionados con el envejecimiento y la pluripatología. Estas trayectorias se pueden observar en el documento NECPAL.

Modelo de atención

La consideración de las necesidades de los pacientes y sus familiares determina un **modelo de atención que reconoce que estos pacientes no constituyen un grupo homogéneo**. Según este modelo:

- A. Numerosos pacientes pueden recibir atención adecuada en el PNA en colaboración con profesionales especializados en CP, que contribuyen cuando es necesario, en la **atención directa o indirecta** (consejos, consultas).

- B. Los pacientes con **necesidades más complejas pueden requerir atención directa periódica o continua de especialistas en CP**¹⁷.

El uso de recursos sanitarios (modalidad de atención) está determinado por los problemas clínicos predominantes, siendo uno la capacidad funcional. Mientras el paciente mantiene la funcionalidad puede recibir CP ambulatorio en un consultorio (primer, segundo o tercer nivel de atención). Cuando presenta mayor declinación funcional, pueden ser tratados de acuerdo a los recursos disponibles: en la casa, en una institución residencial, en una unidad o servicio de CP, en un hospital de agudos, o en un hospice¹⁸.

Los diferentes modelos de prestación de CP definen recursos básicos y especializados, que se separan en 3 niveles de atención¹⁹:

- **Primer nivel o CP primarios:** disponibles para todo paciente que lo necesite allí donde reciba atención sanitaria (ambulatoria u hospitalaria). Debe ser parte de la competencia básica de todo profesional sanitario.
- **Segundo nivel o CP secundarios:** servicio de **apoyo e interconsulta** (realizado por equipos de CP específicos) a los profesionales que prestan CP de primer nivel, siempre que sea necesario para un adecuado control. Se trata de **ayudar, no de sustituir, al primer nivel**. El apoyo debe ser **complementario y la atención, compartida**²⁰⁻²¹.
- **Tercer nivel o CP terciarios:** unidades o camas específicas de ingreso de referencia para atención directa de casos de extrema dificultad que requieran supervisión continuada, y centros promotores de investigación y docencia²².

El **nivel de intervención del equipo de salud** no especializado, debe estar **en función de la complejidad del caso**. **La interconsulta o referencia del paciente nunca debe suponer la separación definitiva ni la renuncia a la responsabilidad continuada en el caso**. Debe realizarse interconsulta o referencia del paciente al nivel de soporte o de ingreso específico en caso de:

- **Criterio de consulta/referencia 1:** dudas diagnósticas o pronósticas del proceso, la enfermedad o alguno de los síntomas de nueva aparición
- **Criterio de consulta/referencia 2:** necesidad de pruebas diagnósticas complementarias o tratamientos que no puedan ser proporcionados o aplicados en el ámbito actual del paciente.
- **Criterio de consulta/referencia 3:** **circunstancias de complejidad** que requieran ayuda para el control sintomático.
- **Criterio de consulta/referencia 4:** cuando en situaciones no previsiblemente complejas:
 - a) **la intensidad del síntoma sea importante (más de 6/10)** y produzca ansiedad en la familia o en el profesional por falta de seguridad en el posible control, y
 - b) **no se consigue el adecuado alivio de** alguno de los síntomas del paciente, tras al menos 2 y nunca más de 3 visitas del profesional del PNA²².

El **IDC Pal**²³, es una herramienta que ayuda a identificar la complejidad de pacientes con enfermedades avanzadas y su entorno familiar.

Se compone de 36 elementos agrupados en tres dimensiones (dependientes del paciente, de la familia o de la organización sanitaria)

El uso de IDC-Pal **permite identificar si la situación es:**

- **No Compleja:** No hay elementos de complejidad ni de alta complejidad presentes
- **Compleja:** Hay, al menos, un elemento de complejidad presente
- **Altamente Compleja:** Hay, al menos, un elemento de alta complejidad presente

(Ver en Anexo Capítulo 1 el Anexo 3)

Otro instrumento para evaluar complejidad es el **hexágono de complejidad (HexCom-Clin)**²⁴,

que incorpora a la valoración los recursos con los que cuentan pacientes y familias.

(Ver en Anexo Capítulo 1 el Anexo 4)

Después de una intervención inicial de evaluación con una **propuesta terapéutica y de los recursos** con los que contamos (personales-familiares-sistema de salud-sociales), es preciso definir, en cada caso, el papel que cada equipo debe desempeñar en el seguimiento, en la atención continua y en la respuesta a situaciones urgentes.

Los equipos específicos de CP se han definido como equipos interdisciplinarios con formación avanzada, con unidad, lugar de atención visible y accesible, documentación y protocolos específicos.

El abordaje es necesariamente integral (requiere de una visión y abordaje multidimensional para poder identificar y abordar apropiadamente las necesidades de la persona y familia).

En el contexto de comprender a la atención paliativa como una atención integral centrada en la persona, es importante comprender el concepto de **sufrimiento**.

Chapman y Gravin (1993) definen el sufrimiento como «un complejo estado afectivo, cognitivo y negativo, caracterizado por la sensación que tiene el individuo de sentirse amenazado en su integridad, por el sentimiento de impotencia para hacer frente a dicha amenaza y por el agotamiento de los recursos personales y psicosociales que le permitirían afrontar dicha amenaza»²⁵.

La sensación de amenaza y el sentimiento de impotencia son subjetivos. El sufrimiento, por tanto, también lo será.

Krikorian y Limonero (2014) definen al sufrimiento como una experiencia multidimensional y dinámica de estrés severo que ocurre ante una amenaza significativa para la integridad de la persona como un todo. Los procesos regulatorios que normalmente conducirán hacia la adaptación resultan ser insuficientes ante dicha amenaza, llevando al agotamiento»²⁶.

Figura 2. El Sufrimiento en contexto

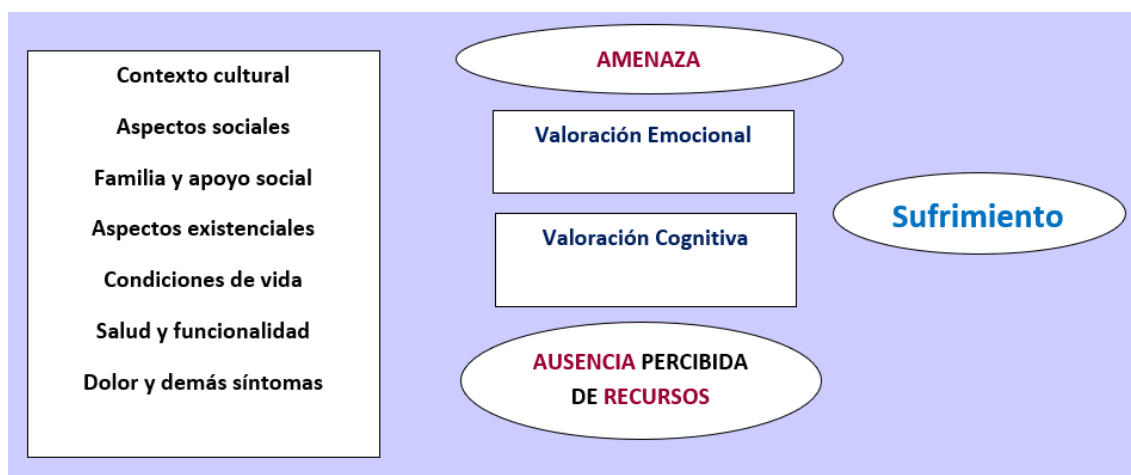


Grafico adaptado ²⁷.

Recursos

La intensidad del sufrimiento y la gran variabilidad en su expresión, puede ser entonces, el resultado del balance de recursos tanto internos como externos, favorables o de factores **distresantes**, que, en su compleja interacción, modulan la percepción, expresión y afrontamiento de situaciones amenazantes para su integridad.

A modo de ejemplo, una persona puede padecer una enfermedad severa, con mal pronóstico a corto plazo (amenaza), con alta vulnerabilidad social (factores desfavorables) pero con amplia red de amigos y soporte espiritual (recursos favorables). Inciden aquí, además, una capacidad intrínseca que se relaciona en gran medida con situaciones aprendidas en el pasado (ejemplo, modo de afrontar vivencias amenazantes en su niñez como la muerte de un ser querido). Surge entonces el concepto de **resiliencia**, que es la capacidad que poseemos como seres humanos de afrontar situaciones adversas o circunstancias traumáticas

Como profesionales de la salud, si deseamos **disminuir el sufrimiento relacionado a la salud de la persona enferma-familia e incrementar su bienestar**, deberíamos entonces:

- Identificar dinámicamente síntomas** (necesidades o problemas) físicos, psicológicos, sociales o existenciales que son percibidos como amenazantes para la persona enferma
- Aliviarlos, atenuarlos, eliminarlos**, lo que se denomina «control de síntomas»
- Identificar y reforzar los propios recursos del enfermo**, para disminuir o atenuar su sensación de impotencia.

Para poder identificar y comprender las necesidades, problemas, recursos, se debe realizar un abordaje multidimensional e interdisciplinario.

Para recordar: “**Recursos y fortalezas**” (extraído y modificado del hexágono de la complejidad)²⁴

este bien

Recursos Intrapersonales: Valores, actitudes y creencias personales que favorecen la adaptación y / o con potencial de transformación

- Rasgos de personalidad firme / resiliencia

Flexibilidad para adaptarse a una situación difícil y cambiante; poder utilizar afrontamientos adaptativos; ser capaz de reinventarse a pesar de la situación

- Tendencia a la toma de decisiones autónomas

Mantener un rol activo frente a la enfermedad, capacidad de tomar sus propias decisiones (incluye la decisión de delegar si así lo prefiere)

- Tendencia a la autorregulación emocional

Conectar con las propias emociones y poder expresarlas; utilizar el humor; técnicas de meditación, arte, etc

Recursos Interpersonales: Valores, actitudes y creencias familiares y / o comunitarias que favorecen la adaptación y / o con potencial de transformación

- Querer y sentirse querido – reconocido, valorado/ capacidad de reparar vínculos/ relaciones armoniosas
- Mantener relaciones positivas/gratificantes (red: seres queridos-amigos, familia-mascotas)
- Mantener una comunicación abierta/ fluida
- Mantener el rol en el sistema familiar, capacidad de adaptación a los cambios de rol y de dejarse cuidar

Recursos Transpersonales: Valores, actitudes y creencias espirituales individuales, familiares y / o comunitarias que favorecen la adaptación y / o con potencial de transformación

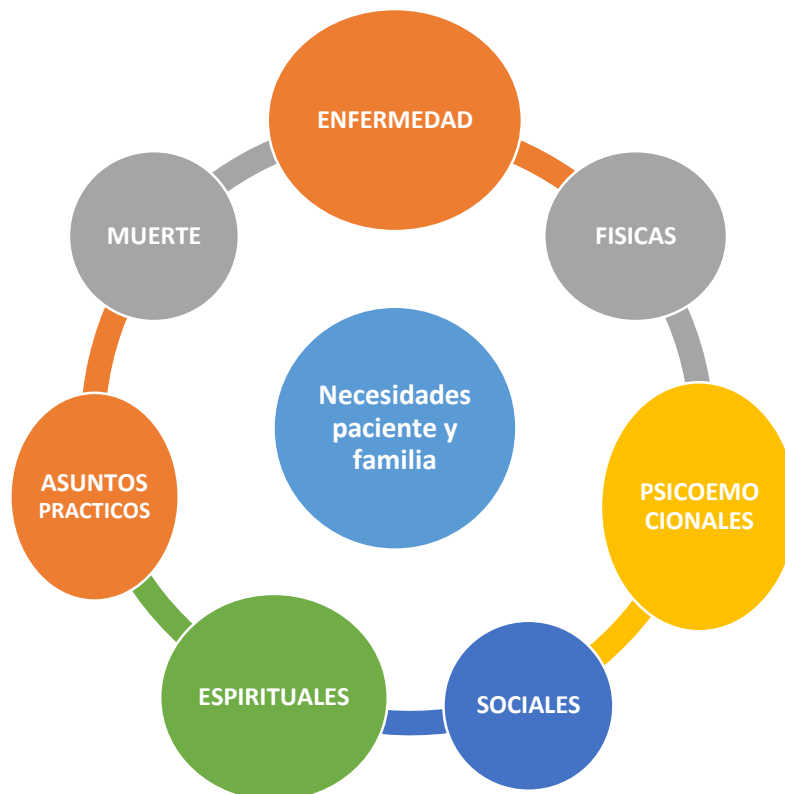
1. **Centrado en el futuro:** confianza en el futuro y esperanza de que pueden pasar cosas buenas; mantener la fe; ser capaz de despedirse, de transmitir el legado, de preparar el propio funeral. Contar con la posibilidad de muerte cercana y sin miedo excesivo. Fuerzas ante la incertidumbre
2. **Centrado en el ahora:** Capacidad de vivir el ahora y el aquí, de agradecer; sentirse en conexión con Dios o la naturaleza o la humanidad. Utilizar técnicas de meditación.
3. **Religiosidad y rituales:** Utilizar la oración; utilizar actos rituales, como velas o celebraciones religiosas

Recursos Prácticos: Conjunto de habilidades y / o capacidades que favorecen la adaptación y / o con potencial de transformación o Uso de objetos materiales o instrumentales que favorecen la adaptación y / o con potencial de transformación

1. **Capacidad de organizarse:** Contar con cuidadora; familia flexible en el cuidar; capacidad resiliente del sistema familiar. Relación de confianza con los profesionales, tener en la zona de equipos competentes y con buena comunicación entre ellos
2. **Capacidad de distraerse:** tv, lectura, música, juegos, regado de plantas, hacer huerta, pasión por viajes, etc.

Necesidades de los pacientes y sus familias

Según **Frank Ferris**, la planificación de actividades, los modelos de servicios de cuidados paliativos y su organización territorial, como así también la formación de profesionales, deben siempre basarse en el análisis de las necesidades que presentan los pacientes y sus familias de una población determinada, como elemento clave. En este sentido, **Ferris ha llevado a cabo una descripción de las diferentes necesidades clasificándolas en grandes grupos o apartados**²⁸.



- **La enfermedad (evaluación y manejo)**

- Diagnóstico primario, evidencia pronóstica.
- Diagnósticos secundarios (demencia, enfermedad mental, traumatismos, etc.).
- Comorbilidad (delirium, insuficiencia orgánica, etc.).
- Efectos adversos medicamentosos (efectos secundarios, toxicidad, etc.).
- Alergias.

- **Necesidades físicas**
 - Estado cognitivo, nivel de consciencia.
 - Función autónoma, dependiente (motora → movilidad, excreción, sentidos → oído, vista, gusto, tacto, olfato; psicológica → descanso/sexual).
 - Ingesta de líquidos y alimentos.
 - Dolor y otros síntomas (cardio-respiratorios; gastrointestinales; condiciones de la boca; condiciones de la piel → sequedad, prurito, exantema, nódulos; generales → agitación, anorexia, caquexia, astenia, debilidad, hemorragia, somnolencia, derrame pleural, ascitis, fiebre, escalofríos –distermia–, incontinencia, insomnio, linfedema, mioclonías, prolapsos, sudor, síncope, vértigo, entre otros).
 - Úlceras.
 - Hábitos tóxicos: tabaco, alcohol, etc.

- **Necesidades psicoemocionales**
 - Personalidad, energía, fuerza, conducta, motivación.
 - Ansiedad, depresión.
 - Emociones (rabia, desesperación, soledad, aislamiento, etc).
 - Miedos (abandono, muerte, ser una carga, etc).
 - Control, dignidad, independencia.
 - Conflicto, culpa, estrés, imitación.
 - Autoimagen, autoestima.

- **Necesidades sociales**
 - Valores culturales, creencias, prácticas.
 - Relaciones familiares, roles familiares, amigos, comunidad.
 - Aislamiento, abandono, reconciliación.
 - Seguridad, entorno confortable.
 - Privacidad, intimidad.
 - Rutinas, rituales, recreaciones, vocación.
 - Recursos económicos, gastos.
 - Asuntos legales (delegación de poderes para finanzas, para gastos de salud, directrices anticipadas, testamento, beneficiarios, etc.).
 - Protección de cuidadores familiares.
 - Tutela, necesidades de custodia.

- **Necesidades espirituales o trascendentes**
 - Sentido vital, valores.
 - Existencial, trascendencia.
 - Valores, creencias, prácticas, afiliaciones.
 - Consultores espirituales, ritos y rituales.
 - Símbolos, iconos.

- **Asuntos prácticos (autonomía, cobertura, accesibilidad)**
 - Actividades de la vida diaria básicas e instrumentales.
 - Cuidador.

- Dependencia, animal de compañía.
- Acceso telefónico, transporte.
- **Necesidades en torno a la muerte (situación de últimos días)**
 - Resolución de asuntos pendientes (por ejemplo, completar los negocios, completar las relaciones, despedirse, etc.).
 - Donaciones (objetos, dinero, órganos, recuerdos, ideas, etc.).
 - Aspectos legales.
 - Preparación para la muerte.
 - Anticipación y manejo de los cambios psicológicos en las últimas horas de la vida.
 - Ritos, rituales.
 - Pronunciamientos, certificación
 -

1. Cuidados Paliativos no especializados o primarios:

Las habilidades de los CP pueden dividirse en **cuatro dominios principales**:

1. **Evaluar y tratar los síntomas físicos.**
2. **Evaluar aspectos psicológicos, sociales, culturales y espirituales de la atención.**
3. **Habilidades de comunicación de enfermedades graves:** comunicación de malas noticias, la obtención de las preferencias del paciente, el establecimiento de objetivos de la atención, la identificación de un sustituto que toma decisiones, decidir sobre el futuro de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y ventilación mecánica, y proporcionar apoyo emocional.
4. **Coordinación de cuidados:** se refiere a la coordinación de la atención que garantice que las transferencias entre los centros de salud sean oportunas y reflejen las necesidades del paciente - familia y metas. Los equipos primarios también deben tener conocimientos básicos sobre cómo derivar pacientes para cuidados paliativos.

Se han realizado esfuerzos para definir las **habilidades de cuidados paliativos no especializados o primarios** y elaborar **criterios para la integración con servicios especializados en cuidados paliativos** en función de estos dominios.

La siguiente tabla muestra las diferencias en las habilidades entre el CP no especializado/primario y el especializado.

Habilidades de CP Primarios	Habilidades de CP Especializados
Evaluación/Tratamiento Síntomas Físicos	
- Manejo básico del dolor y otros síntomas físicos. - Uso básico de analgésicos adyuvantes. - Conversión de dosis equianalgésica.	- Manejo del dolor y otros síntomas refractarios. - Rotación a otro opioide cuando se usan dosis altas de opioides. - Pacientes con problemas de uso indebido de medicamentos y adicción
Aspectos psicológicos, sociales, culturales, espirituales	
- Manejo básico de la depresión / ansiedad. - Exploración del sufrimiento psicosocial. - Exploración básica de puntos de vista espirituales y religiosos. - Encuentro familiar exploratorio básico.	- Manejo de dolor, depresión, ansiedad de difícil manejo. - Sufrimiento existencial severo

Problemas de comunicación	
- Explorar los objetivos del paciente. - Hacer recomendaciones sobre RCP. - Buscar consenso entre los profesionales que tratan. - Buscar el consenso entre el paciente y la familia.	- Pacientes en etapa final de vida que desean se realicen intervenciones desproporcionadas - Conflicto entre los miembros de la familia y/o equipos de tratamiento - Solicitud de eutanasia/suicidio asistido.
Coordinación de cuidados	
- Coordinar la atención entre especialistas. - Definir claramente el equipo primario de tratamiento. - Gestionar transiciones a cuidados paliativos. - Gestionar transiciones fuera del hospital.	- Transición a hospice sin un proveedor claro. - Paciente / familia con dificultad para el cuidado domiciliario. - Conflicto con el equipo ambulatorio designado.

Grafico adaptado²⁹.

Los cuidados paliativos primarios promueven relaciones médico-paciente más sólidas y reducen la fragmentación de la atención. Todos los médicos que atienden a pacientes gravemente enfermos deben comprender los dominios de los cuidados paliativos primarios, recibir capacitación básica en competencias de cuidados paliativos y ser alentados a usar estas habilidades para proporcionar un manejo de la enfermedad de alta calidad y paliación de síntomas a todos los pacientes gravemente enfermos. Involucrar a un equipo especializado adicional en la atención de cada paciente con una esperanza de vida limitada no es eficiente ni deseable, y puede socavar involuntariamente las relaciones terapéuticas existentes y/o deshabilitar al equipo de atención primaria.

Una de las principales razones para capacitar al equipo de salud no especializados en cuidados paliativos para brindar cuidados básicos, pero de calidad, es la gran brecha entre la oferta disponible de especialistas capacitados en cuidados paliativos y la necesidad actual.

Dada la marcada escasez de profesionales especializados en cuidados paliativos en proporción a la demanda, existe una necesidad crítica de refinar la utilización de los servicios especializados en cuidados paliativos. En este sentido, es un objetivo clave, mejorar y difundir la educación y capacitación en habilidades básicas de cuidados y mejorar el acceso a una consulta formal con especialistas, para aquellos pacientes/ grupo familiar más complejos.

Evaluación integral del paciente y su familia

Como hemos descripto previamente, los Cuidados Paliativos (CP) promueven el alivio y la calidad de vida mediante la prevención y tratamiento del sufrimiento evitable de pacientes y familiares, producido por enfermedades serias. Para ello, **la evaluación integral** resulta fundamental ya que permite una mayor comprensión de las necesidades del paciente y su familia, evaluando aspectos de la persona: físicos, psicológicos, sociales y espirituales/existenciales.

La **valoración multidimensional** toma en cuenta los diferentes componentes de la experiencia de síntomas, los cuales son producto de varios aspectos que se deben tener en cuenta para el diagnóstico y de tratamiento. Una valoración de estas características permite reconocer la

interacción de varios síntomas concurrentes entre sí, teniendo en cuenta la influencia de las diferentes dimensiones de la personas: psico-emocional, física, socio-cultural y espiritual.

Es recomendable realizar la valoración de manera continua y regular ya que los pacientes presentan variaciones frecuentes.

Diversas herramientas validadas en cuidados paliativos, pueden ser utilizadas para la evaluación integral. El uso de las mismas variará según cada paciente, tipo de enfermedad y lugar de atención (unidad de cuidados paliativos, consultorio externo, cuidado domiciliario, etc.).

En el proceso de selección de un instrumento de evaluación se debe considerar cuidadosamente los objetivos, su practicidad y aceptación por parte del paciente.

Los instrumentos de evaluación no solo son útiles como instrumento diagnóstico, muchas veces sirven para monitorear la efectividad del tratamiento y detectar efectos adversos a fármacos. Además, juegan un rol importante en la identificación temprana de factores de mal pronóstico que pueden afectar el manejo de síntomas en la enfermedad avanzada. Estos instrumentos deben ser utilizados regularmente.

Los resultados deben ser documentados en la historia clínica para asegurar la precisión en el monitoreo de los síntomas

Una adecuada valoración integral implica:

Indagar sobre:

- Antecedentes familiares
- Antecedentes personales, comorbilidades
- Riesgo de uso inadecuado de sustancias: CAGE (Anexo 5)³⁰: es un cuestionario que se utiliza para evaluar alcoholismo. Es positivo cuando 2 o más preguntas son afirmativas. El SOAPP (Anexo 6)³¹, es un cuestionario rápido y fácil de usar, diseñado para ayudar a detectar pacientes con alto riesgo de uso indebido de opioides. Desde la primera versión, la escala se ha ido modificado a lo largo de los años, siendo publicada también una edición abreviada.³²
- Enfermedad de base: diagnóstico-estudios complementarios, condición pronóstica
- Tratamiento farmacológico y no farmacológico recibidos y actuales

Comprensión y valoración de síntomas

- ¿Qué características tiene el síntoma?
- ¿Cómo se comporta en el tiempo?
- ¿Qué tan intenso es? Severidad: ENA (escala numérica análoga):
 - Leve: 0-3
 - Moderado: 4-6
 - Severo: 7-10³³
- ¿Qué lo mejora o calma? / ¿Qué lo empeora o lo aumenta?
- ¿Qué cree que está causando este síntoma?
- ¿Cómo le afecta a usted o a su familia?
- ¿Qué es lo que más le preocupa?
- ¿Qué objetivos generales debemos tener en cuenta para manejar el síntoma con usted?
- ¿Qué nivel de control considera usted tolerable en una escala de 0 – 10?
- ¿Hay algo, sobre este síntoma que desea comentar por considerarlo importante para usted y su familia?

El ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)³⁴,

es el instrumento más ampliamente utilizado en el contexto clínico de los cuidados paliativos para valoración sintomática. Consiste en una serie de 10 escalas visuales análogas que evalúan síntomas físicos y psicológicos que se encuentran presentes en el momento de aplicarlo y que son frecuentes en enfermedades graves, amenazantes para la vida. Incluye una evaluación del bienestar general y, además, la versión revisada (ESAS-r) agrega un ítem para brindar la posibilidad de valorar algún otro síntoma que el equipo y/o paciente considere relevante. El instrumento es sencillo de utilizar tanto para pacientes como para el equipo tratante, y su implementación puede realizarse en 5 minutos.

Por favor, marque el número que describa mejor cómo se siente AHORA												
Nada de dolor	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	El peor dolor que pueda imaginar
Nada agotado (cansancio, debilidad)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lo más agotado que se pueda imaginar
Nada somnoliento (adormilado)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lo más somnoliento que se pueda imaginar

Sin náusea	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Las peores náuseas que se pueda imaginar
Ninguna pérdida de apetito	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	El peor apetito que se pueda imaginar
Ninguna dificultad para respirar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	La peor dificultad para respirar que se pueda imaginar
Nada desanimado	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lo más desanimado que se pueda imaginar
Nada nervioso (intranquilidad, ansiedad)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Lo más nervioso que se pueda imaginar
Duermo perfectamente	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	La mayor dificultad
Sentirse perfectamente (sensación de bienestar)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Sentirse lo peor que se pueda imaginar
Nada												Lo peor posible
_____ Otro problema (p. ej., sequedad de boca)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Valoración psicosocial

- ¿Cómo se ha adaptado a otros procesos de **enfermedad /duelo?** (experiencias personales o familiares)
- ¿Cómo es el **proceso de adaptación a la enfermedad?**
- ¿Cuáles son sus **preferencias en relación a la comunicación?**
- ¿Cuál es el **grado de información** que presenta/desea?
- ¿Con qué red de apoyo cuenta? (incluye cuidadores, familia y comunidad)
- Conocer la estructura familiar (genograma o familiograma). ¿Cómo son los vínculos familiares?
- ¿Puede identificar uno o más referentes para acompañamiento y toma de decisiones?
- ¿**Cuál es el grado de sobrecarga física y psíquica?**
- ¿**Hay riesgo de duelo complicado?**
- ¿Hay presencia de **enfermedad psicopatológica (paciente y familia)?**

Valoración espiritual³⁵

- ¿Qué es lo que más le preocupa?
- ¿Qué es lo que más le molesta?
- ¿Qué es lo que más le ayuda?
- ¿En qué o en quién se apoya en situaciones de crisis?
- ¿Qué le hace sentir seguro, a salvo?
- ¿Qué es lo que la gente valora más de usted?
- ¿Se siente en paz?
- ¿Tiene alguna creencia/religion?

Valoración funcional y ocupacional

- ¿Cómo es un día típico?
- ¿Cómo realiza las actividades básicas de la vida diaria (alimentarse, ducharse, vestirse, ir al baño, etc.)? ¿Y las instrumentales de la vida diaria (cuidado de otros y del hogar, movilidad en la comunidad, manejo de finanzas, etc.)?
- ¿Qué responsabilidades y tareas tiene? ¿cuáles disfruta?
- ¿Qué actividades le brindan satisfacción? ¿Cuáles considera que son más importantes de hacer?
- ¿Los síntomas interfieren en las actividades de su vida diaria? ¿cómo?

- **Escala de Karnofsky** (Anexo 7)³⁶⁻³⁷

Karnofsky scale of Performance Status (KPS) es una escala numérica que califica el estado funcional de pacientes con enfermedades amenazantes para la vida, o incluso progresión de la fragilidad en personas mayores. La misma valora, entre puntajes del 0 a 100, la capacidad de realizar tareas rutinarias, así como la necesidad de asistencia. Este índice se puede usar para determinar pronóstico, medir los cambios en su funcionalidad o decidir si un paciente puede ser incluido en un estudio clínico. Además, permite evaluar la respuesta al tratamiento y el impacto en la calidad de vida. Ya que el estado funcional y el pronóstico se encuentran relacionados, los resultados de la escala son de ayuda para tomar decisiones clínicas, adecuando la terapéutica para cada paciente. Hay que tener en cuenta que, para la toma de decisiones, es necesario conocer el performance status basal del paciente, ya sea inmediatamente previo a la intercurencia clínica, al contexto de internación o a la aparición de síntomas como dolor u otros.

Debido al uso del KPS para la toma de decisiones, resulta de importancia una evaluación precisa, para lo cual pueden ser útil preguntas que ayuden a determinar el estado funcional como: ¿Hubo pérdida o aumento de peso? ¿Ha tenido alguna reducción en la energía o aumento en la fatiga? ¿Presenta alguna dificultad para vestirse o bañarse? ¿Ha tenido alguna dificultad para caminar o moverse? ¿Ha tenido alguna dificultad para conducir? ¿Tuvo alguna dificultad para trabajar a tiempo completo o parcial?

- **ECOG- PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status)** (Anexo 8)³⁸

Es un instrumento diseñado por el Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) de Estados Unidos y validado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para objetivar la funcionalidad de pacientes con cáncer, en términos de posibilidad de cuidar de sí mismo, realizar actividades diarias y capacidad física (caminar, trabajar, etc.). Este dato es importante cuando se plantea un tratamiento, ya que, a mayor declinación física provocada por la situación de enfermedad, menor posibilidad terapéutica y peor pronóstico.

Sus puntajes van del 0 al 5 y se correlacionan con los valores de 0-100 de la escala de Karnofsky de la siguiente manera:

ECOG	KPS
0	100-90
1	80-70
2	60-50
3	40-30
3	20-10
5	0

- **Índice de Barthel** (Actividades Básicas de la Vida Diaria-ABVD)³⁹ (Anexo 9)

El índice de Barthel se desarrolló para medir la mejora en pacientes con discapacidad crónica que participaban en rehabilitación. Evalúa actividades de la vida diaria, que incluyen ir al baño, bañarse, comer, vestirse, continencia, transferencias y deambulación. Los pacientes reciben puntajes numéricos en función de si requieren asistencia física para realizar la tarea o pueden completarla de forma independiente.

- **FAST (Functional assessment staging tool)**⁴⁰ (Anexo 10)

Reisberg, y colaboradores, unos años después de desarrollar la Global Deterioration Scale (GDS), publican la escala FAST (del inglés Functional Assessment Staging, en castellano: estadificación de la evolución funcional). Comúnmente utilizada para evaluar estado funcional en pacientes con demencia. Provee información sobre la capacidad funcional de la persona, brinda información pronóstica y cuando se combina con información clínica, puede ser de gran ayuda diagnóstica. La escala está compuesta por 7 niveles funcionales principales, que son concordantes con el nivel de cognición y capacidad funcional correspondiente del GDS, aportando a esta última herramienta una división de sus fases 6 y 7 que reflejan la progresiva incapacidad de la persona con demencia para el mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria.

Valoración cognitiva:

- **GDS (Global Deterioration Scale)**⁴¹ (Anexo 11)

La escala GDS se publicó en los años 80 y se la denomina así por las siglas de su nombre original en inglés: Global Deterioration Scale, dicho en castellano: **escala de deterioro global**.

Se suele hacer referencia a ella aludiendo al nombre del neurólogo americano que la desarrolló: Barry Reisberg. La escala GDS contempla 7 fases que, desde la normalidad (GDS 1) a la etapa más grave (GDS 7), define el continuo progreso de la evolución de la demencia degenerativa primaria. El instrumento se utiliza para diagnosticar y determinar el estadio de la demencia del tipo Alzheimer. Al ser una escala diseñada específicamente para este trastorno, refleja con precisión su progresión y desalienta los diagnósticos erróneos.

- **The GDS/FAST Staging System**⁴² (Anexo 12)

Las últimas dos escalas mencionadas, se han unificado años más tarde, para una valoración más integral del paciente con demencia: el Global Deterioration Scale/Functional Assessment Staging (GDS/FAST) system.

Este instrumento ha sido válido para la estadificación de la demencia en la enfermedad de Alzheimer. Abarca, delimita y describe todo el curso del envejecimiento normal y en el contexto de demencia progresiva hasta sus etapas finales.

- **MDAS (Memorial Delirium Assessment Scale)**⁴³ (Anexo 13)

El Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) es un instrumento diseñado para diagnosticar y evaluar la severidad del delirium en pacientes con cáncer avanzado, en cuidados paliativos. Por lo tanto, capta manifestaciones conductuales, así como déficits cognitivos. Esta evaluación mide el deterioro relativo en los siguientes dominios: nivel de conciencia, orientación, memoria a corto plazo, series numéricas, capacidad de atención, organización del pensamiento, alteración de la percepción, ideación delirante, actividad psicomotora, ciclo sueño-vigilia. Los ítems se califican en una escala de 4 puntos, de 0 (ninguno) a 3 (severo), haciendo un máximo posible de 30 puntos, siendo el corte diagnóstico un puntaje de 7. El MDAS es un instrumento relativamente fácil de usar en práctica clínica, que requiere aproximadamente 15 minutos para su administración y se puede aplicar varias veces en un día.

- **CAM (Confusion Assessment Method)**⁴⁴ (Anexo 14)

Este instrumento permite detectar delirium en población geriátrica de forma simple, rápida y precisa en ámbitos clínicos y de investigación. Su aplicación toma 5 minutos y basa el diagnóstico en cuatro criterios:

1. Inicio agudo y curso fluctuante
2. Inatención
3. Pensamiento desorganizado
4. Nivel de conciencia alterado

Para el diagnóstico de delirium es necesario que se encuentren presentes los dos primeros criterios y por lo menos uno de los dos últimos.

Recuerde:

- La evaluación integral es la base para un buen manejo de los pacientes que requieren cuidados paliativos.

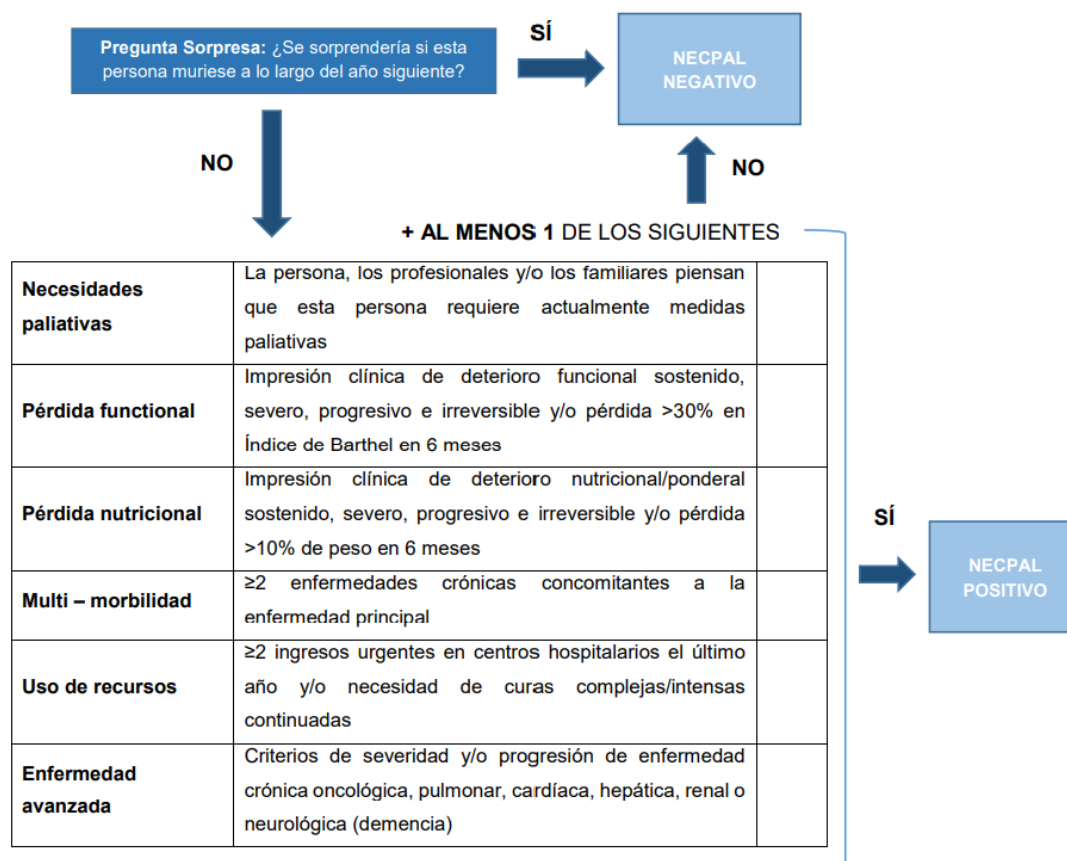
- Piense siempre en evaluar y reevaluar las dimensiones física, psicológica, social y espiritual. **El síntoma es la expresión de todas estas dimensiones.**
- Pregunte por los síntomas, cuál le afecta más su calidad de vida.
- Es importante no adjudicar todos los síntomas a la patología de base. El paciente es mucho más que “una enfermedad”.
- Cualquier estudio o procedimiento debe ser considerado de acuerdo al pronóstico del paciente, objetivo terapéutico y el esfuerzo relativo con el beneficio asociado a la intervención.

La evaluación de y la eficacia de los tratamientos deben ser continuas y requieren los siguientes pasos:

- Los síntomas deben ser evaluados y documentados.
- La valoración debe efectuarse a intervalos regulares después de iniciar el tratamiento y en las diferentes etapas evolutivas de la enfermedad.
- Los pacientes deben ser instruidos para informar sobre algún cambio en las características de los síntomas, favoreciendo la reevaluación apropiada y la consiguiente modificación eventual en el tratamiento.

En los capítulos siguientes, se profundizará la evaluación de diferentes síntomas.

ANEXOS CAPÍTULO 1

Anexo 1 – NECPAL versión 4.0¹⁵

Anexo 2 – SPICT¹⁶**Identifique si existe alguno de los siguientes indicadores generales de mala salud o deterioro:**

- Ingreso(s) hospitalario(s) no planificado(s).
- Limitación funcional o deterioro persistente no reversible (Por ejemplo, la persona permanece en la cama o en una silla durante más de la mitad del día).
- Depende del cuidado de otros debido a sus problemas físicos y / o mentales
- El cuidador de la persona necesita más ayuda y apoyo.
- Pérdida de peso progresiva; se mantiene por debajo de su peso ideal; baja masa muscular.
- Síntomas persistentes a pesar del tratamiento óptimo de la(s) condición(es) subyacente (s).
- La persona (o familia) pide cuidados paliativos; opta por reducir, detener o no recibir tratamiento; o desea centrarse en la calidad de vida.
- Identifique si existen indicadores

Identifique si existen indicadores clínicos de una o varias condiciones asociadas a final de vida.**Cáncer**

- Deterioro funcional debido a la progresión de la enfermedad oncológica.
- Demasiado frágil para el tratamiento del cáncer o tratamiento con objetivo sintomático.

Demencia/Fragilidad

- Incapaz de vestirse, caminar o comer sin ayuda.
- Disminución de la ingesta (comida y bebida). Dificultad para tragar. Incontinencia urinaria y fecal.
- Pérdida de la capacidad para hablar; escasa interacción social.
- Caídas frecuentes; fractura de fémur.
- Episodios febriles o infecciones recurrentes; neumonía aspirativa.

Enfermedad neurológica

- Deterioro funcional y/o cognitivo progresivo a pesar de un tratamiento adecuado.
- Problemas de habla con dificultad creciente para comunicarse y/o dificultad progresiva para tragar.
- Neumonías aspirativas recurrentes; disnea o insuficiencia respiratoria.

- Parálisis persistente después del accidente cerebrovascular con pérdida funcional significativa/discapacidad permanente.

Enfermedad cardiovascular

- Insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria extensa e intratable; disnea o dolor torácico de reposo o a mínimos esfuerzos.
- Enfermedad vascular periférica grave e inoperable.

Enfermedad respiratoria

- Enfermedad pulmonar grave y crónica; disnea de reposo a mínimos esfuerzos entre exacerbaciones.
- Insuficiencia respiratoria persistente que requiere de oxigenoterapia crónica.
- Insuficiencia respiratoria que requiere de ventilación mecánica o contraindicación de ventilación.

Enfermedad renal

- Enfermedad renal crónica en estadio 4 o 5 (TFG <30ml / min) con deterioro del estado de salud.
- Insuficiencia renal que complica otras condiciones asociadas al final de la vida o otros tratamientos.
- Detener o no iniciar la diálisis.

Enfermedad hepática

- Cirrosis, con una o más complicaciones en el último año:
 - ascitis resistente a los diuréticos
 - encefalopatía hepática
 - síndrome hepatorenal
 - peritonitis bacteriana
 - hemorragia recurrente por varices esofágicas
- El trasplante hepático no es posible.

Otras condiciones

- Deterioro y riesgo de morir por otras afecciones o complicaciones que no son reversibles; o que no van a solucionarse con ningún tratamiento.

Revise la situación actual y realice un plan de cuidados

- Revise el tratamiento actual con medicamentos para asegurar que la persona reciba atención óptima; minimize la polifarmacia.
- Considere la derivación al especialista si los síntomas o los problemas son complejos y difíciles de manejar.
- Acuerde con la persona y su familia un plan de cuidados para ahora y para el futuro. Apoye a los familiares cuidadores.

- | |
|---|
| ▪ Planifique anticipadamente si es probable que se pierda la capacidad para tomar decisiones. |
| ▪ Registre, comunique y coordine el plan de cuidados. |

Se considera identificación positiva - requiere Cuidado Paliativo - a cualquier paciente con:

- A. Dos o más indicadores clínicos de deterioro,
- B. Un indicador clínico de enfermedad avanzada y
- C. La “pregunta sorpresa” con respuesta NEGATIVA. (“¿Le sorprendería si este paciente falleciera en los próximos 12 meses?”)

Anexo 3 – IDC PAL²³

		Elementos	Nivel de complejidad*	Sí	No
1. Dependientes del paciente	1.1 Antecedentes	1.1a Paciente es niño/a o adolescente	AC		
		1.1b Paciente es profesional sanitario	C		
		1.1c Rol socio-familiar que desempeña el/la paciente	C		
		1.1d Paciente presenta discapacidad física, psíquica o sensorial previas	C		
		1.1e Paciente presenta problemas de adicción recientes y/o activos	C		
		1.1f Enfermedad mental previa	C		
	1.2. Situación Clínica	1.2a Síntomas de difícil control	AC		
		1.2b Síntomas refractarios	AC		
		1.2c Situaciones urgentes en paciente terminal oncológico	AC		
		1.2d Situación de últimos días de difícil control	AC		
		1.2e Situaciones clínicas secundarias a progresión tumoral de difícil manejo	AC		
		1.2f Descompensación aguda en insuficiencia de órgano en paciente terminal no oncológico	C		
		1.2g Trastorno cognitivo severo	C		
		1.2h Cambio brusco en el nivel de autonomía funcional	C		
		1.2i Existencia de comorbilidad de difícil control	C		
		1.2j Síndrome constitucional severo	C		
		1.2k Dificil manejo clínico por incumplimiento terapéutico reiterado	C		
	1.3. Situación psico-emocional	1.3a Paciente presenta riesgo de suicidio	AC		
		1.3b Paciente solicita adelantar el proceso de la muerte	AC		
		1.3c Paciente presenta angustia existencial y/o sufrimiento espiritual	AC		
		1.3d Conflicto en la comunicación entre paciente y familia	C		
		1.3e Conflicto en la comunicación entre paciente y equipo terapéutico	C		
		1.3f Paciente presenta afrontamiento emocional desadaptativo	C		
2. Dependientes de la familia y el entorno		2.a Ausencia o insuficiencia de soporte familiar y/o cuidadores	AC		
		2.b Familiares y/o cuidadores no competentes para el cuidado	AC		
		2.c Familia disfuncional	AC		
		2.d Claudicación familiar	AC		
		2.e Duelos complejos	C		

3. Dependientes de la organización sanitaria	3.1. Profesional/Equipo	2.f Limitaciones estructurales del entorno	AC		
		3.1a Aplicación de sedación paliativa de manejo difícil	AC		
		3.1b Dificultades para la indicación y/o manejo de fármacos	C		
		3.1c Dificultades para la indicación y/o manejo de intervenciones	C		
		3.1d Limitaciones en la competencia profesional para el abordaje de la situación	C		
	3.2. Recursos	3.2a Dificultades para la gestión de necesidades de técnicas instrumentales y/o material específico en domicilio	C		
		3.2b Dificultades para la gestión y/o manejo de necesidades de coordinación o logísticas	C		

***Nivel de complejidad:** C: Elemento de Complejidad AC: Elemento de Alta Complejidad

Situación: No compleja ☐ Compleja ☐ Altamente Compleja ☐

Intervención de los recursos avanzados/específicos: Sí ☐ No ☐

Anexo 4 – Hexágono de complejidad²⁴

Hexágono de la complejidad (HexCom-Clin®2018). Tablas Guía

1. CLINICA

1.1. Física: malestar físico por síntomas y/o lesiones potencialmente refractarias (dolor disnea, úlcera tumoral)

Baja complejidad

- Control de síntomas y de lesiones con clara evidencia de respuesta, y tiempo previsto, a la acción terapéutica practicada.

Complejidad Media

- Presencia de signos o síntomas de difícil control o potencialmente refractarios o bien lesiones y cuidados con criterios de probable refractariedad.

Alta complejidad

- Persistencia de los signos o síntomas refractarios. Se debe considerar la necesidad de control por medio de ingreso hospitalario.
- Lesiones y/o cuidados que por su evolución, características, riesgos o necesidades terapéuticas pueden necesitar ingreso hospitalario. Ejemplos: riesgo de sepsis (úlceras) por presión sobre infectadas; necesidad de cuidados intensivos (varias veces al día); mutilantes y deformantes (neoplasias de cabeza y cuello); mal olor (neoplasia, gangrena húmeda); riesgo de hemorragia masiva (600 ml / 24 h o 400 ml en 3 horas)

1.2. Terapéutica: dificultad en la adherencia a las prescripciones o por el acceso / aplicación de fármacos o técnicas

Baja complejidad

- Cumplimiento terapéutico asumible, o con garantías de poder asumirlo a pesar de las probables dificultades.
- Situación terapéutica en la que se requieren fármacos o técnicas instrumentales de manejo común o sistematizado en salud comunitaria. Ejemplos: tratamiento con opiáceos, sondaje vesical, técnicas de nutrición enteral, etc.

Complejidad media

- Dificultades en el cumplimiento terapéutico.
- Situación terapéutica en la que se requiere el manejo de fármacos o técnicas instrumentales de uso menos común o no sistematizado en salud comunitaria. Ejemplos: condiciones especiales en el manejo de opiáceos (rotación, nuevos opiáceos, riesgo de toxicidad), manejo de fármacos en niños y adolescentes o en pacientes con hábitos tóxicos, cateterismos, paracentesis evacuadora.

Alta complejidad

- Bloqueo en el cumplimiento terapéutico.
- Situación terapéutica que por sus particularidades en el manejo de los fármacos o técnica instrumental puede requerir tratamiento o ingreso hospitalario. Ejemplos: fármacos vía intravenosa; propofol; ketamina; paracentesis de riesgo (ascitis tabicada, paciente con demencia, deshidratación); toracentesis; cateterismos de riesgo; técnicas de cuidados continuos de alta frecuencia (lavado vesical por hematuria).

2. PSICOLOGICA

2.1. Personalidad: factores de riesgo de vulnerabilidad psicológica (enolismo, toxicomanía, enfermedad psiquiátrica, deterioro cognitivo)

Baja complejidad

- Ausencia de antecedentes o de riesgo de patología psiquiátrica activa.
- Sin indicios de probable trastorno de la personalidad.
- Niega antecedentes de hábitos tóxicos y consumo actual.

Complejidad media

- Antecedentes o riesgo de enfermedad psiquiátrica activa.
- Rasgos de sospecha de trastornos de personalidad.
- Antecedentes o sospecha de hábitos tóxicos y de consumo. Diagnóstico de uso de sustancias.
- Demencia sin trastornos del comportamiento, o con apatía marcada

Alta complejidad

- Patología psiquiátrica activa. Trastorno de personalidad evidente. Ejemplos: perfil y/o comportamiento obsesivo - compulsivo, esquizoide, narcisista (conducta despótica o posesiva), neuroticismo con actitud controladora; responsabilidad diferida (victimismo posicional permanente); psicosis reactiva; etc.
- Demencia con trastornos conductuales
- Presencia de hábitos tóxicos y de consumo. Diagnóstico de abuso y/o dependencia a medicación específica

2.2. Emocional: malestar emocional desadaptativo (intenso, persistente y que dificulta las relaciones)*Baja complejidad*

- Presencia de malestar emocional leve. Ejemplos: cambios de humor, tristeza, ira contra la enfermedad, miedo, llanto, esperanzas realistas, negociación, etc.
- Proceso adaptativo.
- Mantiene la capacidad de afrontamiento resiliente. Estilo de afrontamiento. Buena regulación de los mecanismos de afrontamiento en la función y nivel de exposición procesual de la experiencia traumática. Ejemplos: negación/evitación adaptativa.

Complejidad media

- Persistencia de malestar emocional moderado a pesar de la intervención básica. Ejemplos: persistencia del miedo a sufrir; percepción de pérdida de control, de ser una carga o motivo de sufrimiento, de exclusión (conspiración de silencio, etc.)
- En proceso de ajuste emocional o dificultades adaptativas. Ejemplos: culpabilidad, negación permanente, ira contra el cuidador, metas imposibles, carencia de sentido (parcial), etc.
- En proceso de potenciar la capacidad de afrontamiento resiliente ante la vivencia de adversidad y percepción de amenaza. Dificultad en la regulación de los mecanismos de afrontamiento en la función y nivel de exposición procesual de la experiencia traumática. Ejemplos: dificultades de insight, control del locus interno/externo, tendencia a la hiperactivación (conexión) o hipoactivación (evitación) emocional.
- Síndrome confusional agudo (criterio diagnóstico Confusión Assessment Method (CAM) de manejo difícil.
- Deterioro cognitivo moderado-severo con alteración conductual de manejo difícil

Alta complejidad

- Malestar emocional grave y / o sufrimiento refractario. Ejemplos: persistencia del síndrome de succión por el cuerpo (la enfermedad ocupa toda la vida) de Lain Entralgo; ideación de muerte mantenida y estructurada (ideación autolítica, suicidio diferido); ansiedad y / o depresión grave (desesperación, abandono vital); miedo como bloqueo emocional (terror, crisis de pánico, fobia específica a dormir / morir), etc.
- Proceso desadaptativo. Que puede ser compatible con trastorno psicológico.
- Anulación o "bloqueo persistente" de las capacidades de afrontamiento resiliente. Insuficiente regulación de los mecanismos de afrontamiento en la función y nivel de exposición procesual de la experiencia traumática
- deterioro cognitivo moderado-severo (5 o más errores Test de Pfeiffer) con alteración conductual refractaria a la intervención
- síndrome confusional agudo (criterio diagnóstico Confusión Assessment Method (CAM) refractario.

3. ESPIRITUAL

3.1. Sentido: Incapacidad para encontrar sentido a la situación (no poder mantener la coherencia en el ser/hacer, sentirse roto por la enfermedad)

Baja complejidad

- Coherencia con la vida vivida. Sentimiento de paz hacia los hechos y acciones practicadas.
- Capacidad de hacer balance de vida sin malestar emocional significativo, de expresar cuál es su sentido y de identificar los motores que lo han conducido.
- Expresión del malestar emocional desde la serenidad. Puede vivir el día, disfrutar y utilizar los propios recursos de afrontamiento.

Complejidad media

- Sentimiento de falta de coherencia con las acciones y decisiones practicadas durante su vida.
- Malestar espiritual: sentimientos de crisis de sentido de su vida a causa de la enfermedad.
- Sentimiento de culpa en la relación consigo mismo.
- Sufrimiento espiritual relacionado con la desconexión con sí mismo (pérdida de conexión con la propia intimidad, con su propio ser). Presencia de angustia por la proximidad de la muerte, pero puede disfrutar de momentos durante el día y de las relaciones y recurso personal que le ayuda a sostener y modular los síntomas identificables.
- Posible necesidad de medicación para el manejo de la desazón / sufrimiento.

Alta complejidad

- Presencia de sufrimiento espiritual con pérdida de sentido de vida.
- Desconexión de sí mismo (pérdida de conexión con la propia intimidad, con su propio ser) con malestar físico. Incapacidad de encontrar la paz.
- Desesperanza, pérdida del sentido de la vida que se manifiesta con angustia persistente.
- Necesidad de medicación por el manejo del sufrimiento espiritual.

3.2. Conexión: Incapacidad de amar y de sentirse amado (Aislamiento existencial, culpa)

Baja complejidad

- Ama y se siente amado/a.
- Sentido de pertenencia con los seres cercanos (familia, amigos) conservado.
- Capacidad de transmitir su legado (la parte de él / lo que perdurará, lo que ha enseñado a sus seres queridos).
- Necesidad de reparar las relaciones (gestión del perdón: perdonar / ser perdonado) y hacer cierre de vida desde la serenidad.
- Puede vivir el día, disfrutar y utilizar los propios recursos de afrontamiento.

Complejidad media

- Relación con los otros caracterizada por el sentimiento de culpa.
- Sufrimiento debido a no sentirse ni comprendido, ni reconocido como persona, ni por todo lo que ha hecho por sus seres queridos.
- Pérdida del sentido de pertenencia con respecto a sus seres queridos (familia, amigos).
- Convicción de no haber amado lo suficiente, pero capacidad de disfrutar de momentos durante el día y de las relaciones.
- Posible necesidad de medicación psicofarmacológica para el manejo del sufrimiento emocional.
- Expresión de enojo hacia los suyos por no sentirse querido

Alta complejidad

- Sufrimiento espiritual debido a la desconexión con los demás. Necesidad de aislamiento social.
- Sentimiento recurrente de culpa por todo lo que no ha hecho por los demás. Rotura de las relaciones familiares.
- Sufrimiento debido a no sentirse querido ni perdonado por los demás.
- Sentimiento de soledad predominante. Incapacidad de encontrar la paz y la serenidad.
- Necesidad de medicación psicofarmacológica para el manejo del malestar emocional grave y la desesperación.

3.3. Trascendencia: Incapacidad para afrontar todo lo que sobrevendrá (falta de confianza ante el desconocido y/o el futuro. Pánico en la muerte, pánico al futuro de los que se deja).

Baja complejidad

- Sustrato basal de confianza y serenidad.
- Confianza en "lo que tenga que pasar irá bien", falta de miedo a la muerte, certeza de destino. Esperanza.
- Convicción de poder afrontar el proceso de morir. Expresión de los valores y creencias que le ayudan a sostener la situación.
- Capacidad de expresar su legado (lo que ha aportado y perdurará en su ausencia).
- Posibilidad de incertidumbre ante lo desconocido, pero expresada con serenidad que le permite vivir el día, disfrutar y utilizar sus propios recursos (como orar y/o creer en su potencial para sostener lo que vendrá).

Complejidad media

- Malestar espiritual, con sentimientos de injusticia. Vivencia de castigo y abandono por parte de Dios. Ira hacia Dios / Vida / Destino ...
- Malestar por no poder valorar y/o no ser valorado su legado en el mundo.
- Sufrimiento espiritual con impotencia y victimismo (sentirse solo ante el precipicio).
- Falta de preparación para la muerte. Angustia / miedo hacia la muerte.
- Falta de sentido de la muerte, dificultad en el desprenderse, en el manejo del no-control, del misterio (personalidad controladora, muy racional).
- Fe/confianza insuficiente para afrontar lo que vendrá. Necesidad de reconciliarse con lo trascendente.
- Malestar basal, pero puede disfrutar de momentos durante el día y de las relaciones con los demás y con lo trascendente.
- Posible necesidad de medicación psicofarmacológica para el manejo del malestar emocional/sufrimiento.

Alta complejidad

- Sufrimiento espiritual relacionado con el sentimiento de pérdida de control.
- Pérdida de esperanza/desesperanza.
- Angustia/miedo a la propia desaparición/desintegración/extinción.
- Incapacidad para poder valorar/expresar su legado (lo que ha aportado y perdurará en su ausencia).
- Falta de recursos para afrontar/sostener el momento de morir (sentimiento de caída libre sin paracaídas). Desconexión con la dimensión trascendental de sí mismo (de su fuerza interna): desfallecimiento.
- Sentimiento de que está solo ante aquello desconocido.
- Convicción de culpa inexorable y castigo merecido.
- Expresión de desasosiego que se acompaña de malestar físico y emocional. No identificamos recursos efectivos para hacer frente a la vivencia de enfermedad y de la percepción de muerte cercana.
- Necesidad de sedación para el manejo del sufrimiento espiritual.

4. SOCIOFAMILIAR**4.1. Relacional:** Malestar relacional familiar que dificulta la atención al familiar*Baja complejidad*

- Buena relación entre persona enferma y cuidador o referente (vinculación estrecha).
- Buena comunicación verbal y no verbal en todas las áreas relacionales (logística diaria, vivencia de enfermedad, toma de decisiones, abordaje de la situación de final de vida).
- Ámbito relacional armónico. Relación facilitadora de la atención en el domicilio hasta el final de la vida.
- Relación familiar (hijos, padres, hermanos, etc.) sin dificultades.

Complejidad media

- Relación entre persona enferma y cuidador o referente, predominantemente ambivalente o dependiente (uni o bidireccionalmente).
- Poca comunicación verbal y no verbal en algunas áreas relacionales (logística diaria, vivencia de enfermedad, toma de decisiones, abordaje del final de la vida).
- Relación poco facilitadora de la atención en el domicilio hasta el final de la vida.
- Alguna dificultad más específica en las relaciones familiares (hijos, padres, hermanos, etc.).

Alta complejidad

- Relación entre persona enferma y cuidador o referente, conflictiva o muy distante.

- Comunicación verbal y no verbal difícil o conflictiva (logística diaria, vivencia de enfermedad, toma de decisiones, abordaje del final de la vida). Malestar en cualquier área.
- Relación que no posibilita que la persona enferma pueda estar en el domicilio. Riesgo o indicios de maltrato verbal y no verbal (uni o bidireccional).
- Relaciones familiares distantes, conflictivas y / o rotas (hijos, padres, hermanos).

NOTA: Se valora la relación familiar que genera más distorsión en el cuidado del enfermo

4.2. Emocional: malestar emocional desadaptativo (intenso, persistente y que dificulta las relaciones) y que dificulta el cuidar al enfermo

Baja complejidad

- Impacto emocional y/o estado emocional con respuestas adaptativas del cuidador o persona referente que posibilitan la atención de la persona enferma en el domicilio hasta el final de la vida.
- Equilibrio entre la capacidad emocional y la carga emocional. Capacidad de autocuidado intacta.
- Comunicación emocional abierta entre enfermo, cuidador o referente y/u otros familiares (comparten las emociones, preocupaciones o aprendizajes generados por la vivencia de la enfermedad). Buena conexión y expresión de las emociones.
- Fuerte sentido de realización personal. El cuidador o persona referente encuentra significado a la vivencia de cuidar.
- Sentido de reciprocidad ("tengo cuidado de quien me ha cuidado o me cuidaría").
- Duelos anteriores resueltos o en proceso de buena elaboración.

Complejidad media

- Presencia de algunas dificultades emocionales adaptativas, que permitirían, al cuidador o persona referente, la atención de la persona enferma en el domicilio.
- Signos de carga emocional no compensada. Limitaciones en la capacidad de autocuidado.
- Enfermo y cuidador o referente y otros familiares hablan poco o indirectamente de las emociones, preocupaciones y aprendizajes que les genera la vivencia de la enfermedad. Poca conexión y expresión de las emociones.
- Sentido de realización personal bajo. Pobre significado de la vivencia de cuidar.
- Bajo sentido de reciprocidad.
- Duelos anteriores no resueltos o en proceso de elaboración complejo. Riesgo de duelo complicado.

Alta complejidad

- Respuestas emocionales desadaptativas del cuidador o persona referente que bloquean la atención y cuidado del enfermo en el domicilio.
- Signos de agotamiento integral. Limitaciones severas en la capacidad de autocuidado.
- Protección en la conexión y expresión de las emociones. No se habla de aspectos emocionales derivados de la vivencia de la enfermedad.
- Ninguna expresión / sentido de realización personal. Carece de significado de la vivencia de cuidar.
- Ninguna expresión / sentido de reciprocidad.
- Duelos anteriores: presentes y activados
- Duelos complejos

4.3. Práctica: Dificultad en el manejo de las necesidades básicas del enfermo (higiene, comida).

Baja complejidad

- El cuidador o la persona referente pueden ofrecer la atención y cuidado que el enfermo necesita de forma plena e integral.
- Ausencia de expresión o de signos de sobrecarga relacionada con la tarea de cuidar.
- Equilibrio entre las probables cargas y las posibilidades de atención.
- Capacidad de autocuidado del cuidador o persona referente: contemplada y factible
- El cuidador o la persona referente dispone de tiempo y espacios personales y los utiliza.
- Vivienda: condiciones adecuadas a las necesidades

Complejidad media

- El cuidador o la persona referente no puede garantizar la atención plena e integral de las necesidades del enfermo.
- Expresión o presencia de signos de sobrecarga y / o dificultades en relación con la tarea de cuidar.
- Desequilibrio entre las cargas y las posibilidades de atención
- Disminución de la capacidad de autocuidado del cuidador o persona referente.
- El cuidador o la persona referente dispone de poco tiempo y espacios personales o si los tiene, pero no los utiliza.
- Vivienda: con barreras arquitectónicas internas y / o externas. Falta de espacio

Alta complejidad

- El cuidador o la persona referente no puede ofrecer la atención y cuidado que el enfermo necesita.
- Expresión o percepción clara de sobrecarga y / o dificultades que evidencian la imposibilidad de cuidar al enfermo en el domicilio.
- Fractura entre las cargas y las posibilidades de atención.
- Autocuidado del cuidador o persona referente: impracticable. El cuidador o persona referente no dispone de tiempo ni espacios para la atención personal.
- Ausencia de cuidador / o persona referente
- Indicios o sospecha de negligencia o malos tratos (actuales o anteriores): cuidador al enfermo y / o enfermo al cuidador.
- Vivienda altamente inadecuada
- Hace falta un ingreso sociosanitario del paciente

4.4. Externa: Dificultad en tener o aceptar ayuda efectiva externa al núcleo de convivencia (entorno familiar-amistades)

Baja complejidad

- Familia extensa y unida. Soporte factible y garantizado.
- Soporte importante de vecinos o amigos.
- Soporte de servicios sanitarios y sociales: hay poca intervención o ésta se prevé suficiente para garantizar la atención de la persona enferma en el domicilio hasta el final de la vida.

Complejidad media

- Familia nuclear, poco extensa, extensa con dificultades de apoyo. Soporte limitado.
- Soporte puntual de vecinos o amigos.
- Soporte de servicios sanitarios y sociales: La intervención no puede garantizar la continuidad de la atención del enfermo en el domicilio.

Alta complejidad

- Familia monoparental y / o núcleo familiar sin apoyo familiar externo válido.
- Ningún apoyo factible de vecinos ni de amigos.
- No es sostenible la situación en el domicilio de forma razonablemente digna para el enfermo y la familia a pesar de la intervención de los servicios sanitarios y sociales de apoyo

4.5. Económica: Malestar financiero o imposibilidad de contratar ayuda externa (Trabajadora familiar)

Baja complejidad

- Recursos económicos suficientes (cobertura de necesidades básicas: comida, gasto energético, hogar, fármacos...)
- No expresan ningún sufrimiento o problemas familiares a raíz de gastos económicos.
- Pueden alcanzar, en su caso, gastos de salud no subvencionados (cuidador privado, psicólogo...).

Complejidad media

- Recursos económicos insuficientes (alguna dificultad en la cobertura de necesidades).
- Expresan estrés o problemas familiares a raíz de gastos económicos.
- Podrían alcanzar en algún caso o temporalmente, gastos de salud no subvencionados

Alta complejidad

- Escasos o nulos recursos económicos (dificultades severas y / o imposibilidad de cobertura de las necesidades básicas).
- Expresan sufrimiento y / o problemas familiares importantes a raíz de gastos económicos.
- De ninguna manera podrían alcanzar gastos de salud no subvencionados

5. ETICA

5.1. Información: Dificultad en el manejo de la información sobre el diagnóstico o el pronóstico

Baja complejidad

- No hay conflicto respecto a las necesidades de información y comunicación del paciente y, en caso de conflicto, el equipo de referencia lo resuelve de forma efectiva.

Complejidad media

- Persistencia de conflicto a pesar de la intervención del equipo de referencia.

Alta complejidad

- Presencia de sufrimiento vital refractario secundario a la persistencia de conflicto con respecto a la información y la comunicación. Ejemplo: situación de crisis de conocimiento (A. Stedeford 1984). Conspiración de silencio refractario. Negación de información a algún familiar relevante

NOTA: No confundir conspiración (el enfermo demanda información) con pacto (el enfermo no demanda información)

5.2. AET: Dificultad en la toma de decisiones clínicas (adecuación del esfuerzo diagnóstico/terapéutico, limitación o rechazo).

Baja complejidad

- El paciente (o su representante autorizado) ha expresado su voluntad sobre la intervención terapéutica y el nivel de intensidad de su aplicación. No hay conflicto en que aquella y los términos establecidos sean respetados por la familia y los profesionales.

Complejidad media

- Existen dificultades para que el paciente exprese su voluntad, por la preservación de la misma y los acuerdos establecidos con este fin o para garantizar su continuidad. Ejemplo: falta de coordinación o disparidad de criterios entre profesionales, servicios o niveles asistenciales.

Alta complejidad

- Presencia de sufrimiento grave en el paciente, la familia y los profesionales debido a la persistencia del conflicto en el tiempo.
- Discrepancia insalvable entre el posicionamiento o la voluntad del paciente y el del equipo sobre la medida terapéutica que se debe aplicar o la proporcionalidad de esta medida
- Enfermo no claramente competente y sin representante apropiado

NOTA: Valorar el nivel de competencia del enfermo y del cuidador para la toma de decisiones

NOTA: Valorar el nivel de intensidad terapéutica ajustado al caso concreto y consensuado

5.3. DAM: Manifestación expresa de deseo de anticipar la muerte como la única salida al sufrimiento (puede haber distintos grados: pensamiento, intención, decisión, plan, petición)

Baja complejidad

- Cuando el deseo de anticipar la muerte se manifiesta de manera esporádica y que en el propio entorno familiar y de amistades queda acogido y trascendido.

Complejidad media

- El DAM es un deseo mantenido en el tiempo -aunque pueda ser fluctuante- y que el enfermo ve como la única salida a su sufrimiento, pero que valoramos que con apoyo específico el enfermo podrá en cierto modo superar.

Alta complejidad

- Se refiere a la petición de eutanasia, suicidio asistido o planificación suicida. Denota un sufrimiento grave y potencialmente refractario.

NOTA: no confundir DAM con aceptación de la muerte, ni con el deseo de la familia de adelantar la muerte en SUD

6. MUERTE

6.1. Ubicación: Dificultad para planificar el lugar donde morir (desacuerdo enfermo-familia-equipo) o petición de morir ingresado

Baja complejidad

- SUD con previsión de apoyo cuidador suficiente en el domicilio.
- Enfermo y familia expresan estar de acuerdo en que el éxitus se produzca en el domicilio.
- Disponibilidad del equipo de referencia y factibilidad de la atención (intensificación de visitas: revisión diaria garantizada de la situación, logística adecuada: conocimientos y práctica en el uso de fármacos y la técnica de sedación).
- No se plantea el ingreso hospitalario.

Complejidad media

- SUD con probable apoyo cuidador insuficiente en el domicilio.

- Falta de acuerdo entre el enfermo y la familia en relación a que el lugar del éxitus sea el domicilio.
- Baja disponibilidad del equipo de referencia y de factibilidad de la atención (intensificación de visitas: revisión diaria garantizada de la situación, logística adecuada: conocimientos y práctica en el uso de fármacos y la técnica de sedación).
- Sin dificultades en la opción de drenaje en situación susceptible de ingreso hospitalario.

Alta complejidad

- Expresión reiterada de incapacidad familiar para asumir la SUD y la muerte en el domicilio.
- Demanda urgente de ingreso por parte del paciente y / o familia.
- Abrupto e inesperado cambio clínico que provoca la activación de los servicios de urgencia y el traslado al hospital.
- Carencia de opción de drenaje en situación susceptible de ingreso hospitalario.
- Dificultades en la opción de drenaje en situación susceptible de ingreso hospitalario.

NOTA: marcaremos A cuando la situación clínica o sociofamiliar propicien un traslado urgente a hospital

NOTA: marcaremos N si no se ha planteado en ningún momento la ubicación del éxitus

6.2. SUD situación de últimos días: Dificultad en el manejo del proceso de morir (síntomas refractarios, duración >4 días, sedación difícil o confusión con eutanasia)

Baja complejidad

- SUD sin necesidad de atención directa para el equipo (incluye muerte espontánea...).
- SUD con poca sintomatología. Ausencia de síntomas traumáticos o refractarios. Sedación practicable con fármacos y dosis habituales.
- Situación emocional adaptativa del paciente y la familia con familia implicada en el cuidado del enfermo.
- Ausencia de dilemas éticos o con un consenso claro sobre estos. Sedación con indicación y comprensión clara. Ausencia de conflicto respecto al consentimiento (paciente o representante autorizado).
- Disponibilidad del equipo de referencia y factibilidad de la atención (intensificación de visitas: revisión diaria garantizada de la situación, logística adecuada: conocimientos y práctica en el uso de fármacos y la técnica de sedación).

Complejidad media

- Sedación de comprensión difícil (fácil asociación a eutanasia).
- Existencia de conflicto, respecto a la indicación de sedación, entre paciente / familia y equipo. Ejemplos: paciente con pánico; miedo a dormir / morir; situación de no dejar morir. Situación de indicación urgente de sedación sin consentimiento ni representante autorizado. Dificultad logística en poder asumir o adaptarse a los cambios que se requieren en la estrategia de intervención, en la SUD por el equipo de referencia.

Alta complejidad

- Presencia o riesgo de aparición de síntomas traumáticos o refractarios.
- SUD de larga duración (> 5 días).
- Sedación refractaria con necesidad de fármacos a dosis altas y vía intravenosa.

NOTA: si el enfermo no está en SUD en la valoración inicial, se considera complejidad N

NOTA: si el enfermo entra en SUD en otro servicio (urgencias, hospitalización), se considera complejidad N

6.3. Duelo: Presencia de factores de riesgo de duelo.

Baja complejidad

- Ausencia de factores de riesgo en el duelo.

Complejidad media

- Presencia de indicadores de factores de riesgo en el duelo.

Alta complejidad

- Presencia de indicadores psicológicos de alta vulnerabilidad de duelo complejo y/o de alteraciones psicopatológicas previas.

NOTA: Factores de riesgo de duelo: Juventud del enfermo o del cuidador, estrategias de afrontamiento pasivas, enfermedad física/psíquica anterior, apego o relación ambivalente o dependiente con el enfermo, ser su padre-madre, esposo o hijo, bajo nivel de desarrollo familiar, muerte súbita o imprevista, larga duración de la enfermedad, control de síntomas deficiente, falta de soporte familiar y social, bajo nivel de comunicación, incapacidad para expresar la pena, pérdida inaceptable socialmente, duelos previos no resueltos, pérdidas múltiples, crisis concurrentes, obligaciones múltiples (Pilar Barreto et al. 2012)

NOTA : Según el Manual DSM - V , el diagnóstico de Duelo Complicado se realiza a partir de los 6 meses posteriores a la muerte

RECURSOS Y FORTALEZAS (RYF)

Intrapersonales: Valores, actitudes y creencias personales que favorecen la adaptación y/o con potencial de transformación (cambio)

1. **Rasgos de personalidad firme/resiliencia**
(Tener flexibilidad para adaptarse a una situación difícil y cambiante; poder utilizar afrontamientos adaptativos; ser capaz de reinventarse a pesar de la situación; capacidad de proteger y preservar el "self")
2. **Tendencia a la toma de decisiones autónomas**
(Mantener un rol activo frente a la enfermedad, tener la capacidad de tomar la iniciativa en la toma de decisiones; dar valor a ser autónomo; saber delegar; mostrar asertividad en pedir lo que necesita).
3. **Tendencia a la autorregulación emocional**
(Mantener una buena regulación emocional ante la situación de amenaza; conectar con las propias emociones y poder expresarlas; utilizar el humor; utilizar técnicas de meditación o *mindfulness*; mantener la creatividad- tocar un instrumento, escribir, pintar)

Interpersonales: Valores, actitudes y creencias familiares y/o comunitarias que favorecen la adaptación y/o con potencial de transformación (cambio)

1. **Querer y sentirse querido**
(Disfrutar de un tono de cuidado amoroso; tener la capacidad de reparar vínculos significativos; sentirse reconocido; mantener una buena relación con la pareja, tener un cuidador que encuentra sentido en cuidar del otro; capacidad de la familia de apoyar las decisiones del enfermo)
2. **Mantener relaciones positivas**
(Mantener relaciones gratificantes con hijos, nietos, mascotas; disfrutar de una amplia red de amistades)
3. **Mantener una comunicación abierta.**
(Ser capaz de mantener la fluidez en la comunicación)
4. **Mantener el rol en el sistema familiar**
(Tener la capacidad de preservar el rol dentro del sistema familiar; capacidad de adaptación a los cambios de rol; tener la capacidad de dejarse cuidar)

Transpersonales: Valores, actitudes y creencias espirituales individuales, familiares y/o comunitarias que favorecen la adaptación y/o con potencial de transformación (cambio)

1. **Centrado en el futuro**
(Tener confianza en el futuro, mantener la esperanza de que pueden pasar cosas buenas; mantener la fe; ser capaz de poder despedirse; ser capaz de poder transmitir el legado; ser capaz de poder preparar el propio funeral; contar con la posibilidad de muerte cercana y no tener demasiado miedo; no tener miedo a la muerte; sentir que se tiene fuerzas ante la incertidumbre)
2. **Centrado en el ahora:**
(Tener la capacidad de vivir el ahora y el aquí; sentirse en conexión con Dios o la naturaleza o la humanidad; ser capaz de utilizar técnicas de meditación, tener la capacidad de agradecer)
3. **Religiosidad y rituales**
(Utilizar la oración; utilizar actos rituales, como velas o celebraciones religiosas)

Prácticos: Conjunto de habilidades y/o capacidades que favorecen la adaptación y/o con potencial de transformación (cambio) o Uso de objetos materiales o instrumentales que favorecen la adaptación y/o con potencial de transformación (cambio)

1. **Capacidad de organizarse**
(tener cuidadora privada; tener una familia flexible en el cuidar; capacidad resiliente del sistema familiar, tener una relación de confianza especial con los profesionales, tener en la zona de equipos competentes y con buena comunicación entre ellos)
2. **Capacidad de distraerse:**

(Poder distraerse con la tv, la lectura, la música, sudoku; poder ir a hacer el café; poder regar las plantas, el huerto; poder mantener la pasión por los viajes, las excursiones; poder ir y llevar el coche)

NOTA: El malestar emocional y la percepción de amenaza inherente a la enfermedad avanzada, activa respuestas de afrontamiento que modulan la capacidad de adaptación del paciente y familiares. Se considera que cualquier respuesta de afrontamiento, sea temporal o defensa rígida, tiene una funcionalidad y capacidad psicológica reguladora que puede contribuir en el proceso de asimilación de la experiencia de sufrimiento

NOTA: Los (RyF) son transversales y interrelacionado entre sí. A la hora de realizar la clasificación, un mismo RyF puede pertenecer a más de un tipo.

Anexo 5 – Cuestionario CAGE³⁰

C: ¿Ha sentido alguna vez que debía beber menos? Have you felt the need to Cut down drinking?

Busca intentar reducir el consumo de alcohol y revela los problemas individuales que surgen del abuso.

A: ¿Le ha molestado que la gente lo critique por su forma de beber? Have you ever felt Annoyed by criticism of drinking?

Encubre las consecuencias sociales negativas del consumo abusivo de alcohol y es el menos sensible y específico de los ítems.

G: ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por su forma de beber? Have you had Guilty feelings about drinking?

Los sentimientos de culpa pertenecen a la dimensión psicopatológica del consumo excesivo de alcohol y son realmente frecuentes en estos trastornos.

E: ¿Alguna vez ha necesitado beber por la mañana para calmar los nervios o eliminar molestias por haber bebido la noche anterior? Do you ever take a morning Eye opener (a drink first thing in the morning to steady your nerves or get rid of a hangover)?

Es casi patognomónico de dependencia (especificidad alrededor del 100% y alto VPP, en torno a 84% en algunos estudios). No tiene prácticamente falsos positivos.

Según el número de respuestas afirmativas, en general se considera que cuanto mayor es, mayor será también la dependencia. De este modo:

- 0-1: Bebedor social
- 2: Consumo de riesgo. Sensibilidad >85% y especificidad alrededor del 90% para el diagnóstico de abuso/dependencia
- 3: Consumo perjudicial
- 4: Dependencia alcohólica.

Anexo 6 – SOAPP-R: Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain³¹

Evaluación de opioides para pacientes con dolor	
Las siguientes son algunas preguntas dadas a pacientes que están en tratamiento o que están siendo considerados para medicación para su dolor. Por favor conteste cada pregunta lo más honestamente posible. No hay respuestas correctas o incorrectas.	
1. ¿Con qué frecuencia tiene cambios de humor?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
2. ¿Con qué frecuencia ha sentido la necesidad de dosis más altas de medicamentos para tratar su dolor?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
3. ¿Con qué frecuencia te has sentido impaciente con tus médicos?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
4. ¿Con qué frecuencia has sentido que las cosas son demasiado abrumadoras que no puedes manejarlos?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
5. ¿Con qué frecuencia hay tensión en el hogar?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
6. ¿Con qué frecuencia ha contado las pastillas para el dolor para ver cuántas quedan?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
7. ¿Con qué frecuencia le ha preocupado que la gente lo juzgue por tomar analgésicos?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
8. ¿Con qué frecuencia te sientes aburrido?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
9. ¿Con qué frecuencia ha tomado más analgésicos de los que debía?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
10. ¿Con qué frecuencia te ha preocupado que te dejen solo?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
11. ¿Con qué frecuencia has sentido ansias de medicación?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
12. ¿Con qué frecuencia han expresado otras personas su preocupación por el uso de tus medicamentos?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
13. ¿Con qué frecuencia alguno de sus amigos cercanos ha tenido problemas con el alcohol o las drogas?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
14. ¿Con qué frecuencia le han dicho otros que tuvo mal genio?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
15. ¿Con qué frecuencia te has sentido consumido por la necesidad de obtener medicamentos para el dolor?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
16. ¿Con qué frecuencia te has quedado sin medicamentos para el dolor antes de tiempo?	Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐

17. ¿Con qué frecuencia otros te han impedido obtener lo que mereces?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
18. ¿Con qué frecuencia, en su vida, ha tenido problemas legales o ha sido arrestado?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
19. ¿Con qué frecuencia ha asistido a una reunión de AA o NA?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
20. ¿Con qué frecuencia has estado en una discusión que estaba tan fuera de control que alguien resultó herido?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
21. ¿Con qué frecuencia has sido abusado sexualmente?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
22. ¿Con qué frecuencia otros han sugerido que tiene un problema de drogas o alcohol?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
23. ¿Con qué frecuencia ha tenido que tomar prestados medicamentos para el dolor de su familia o amigos?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐
24. ¿Con qué frecuencia ha sido tratado por un problema de alcohol o drogas?
Nunca ☐ Rara vez ☐ A veces ☐ A menudo ☐ Muy a menudo ☐

Solo para ser calificado por el profesional, no por el paciente

Por favor use la escala de abajo para otorgar puntuación a las preguntas antes mencionadas
0 = Nunca, 1 = Rara Vez, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Muy a menudo

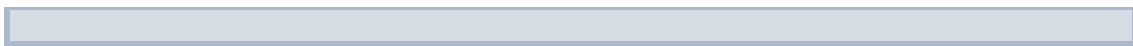
Puntuación = **Nunca** **Rara Vez** **A veces** **A menudo** **Muy a menudo**

Riesgo de uso indebido de opioides

Riesgo Bajo - puntuación < 9
Riesgo Moderado - puntuación 10 a 21
Riesgo Elevado - puntuación 22 o mayor

SOAPP SF (versión abreviada)³²

¿Con qué frecuencia...?				
1. ¿presenta cambios de humor?				
2. ¿fuma un cigarrillo dentro de la primer hora de levantarse?				
3. ¿ha usado medicación no prescrita?				
4. ¿ha utilizado usted drogas ilegales en los últimos 5 años?				
5. ¿ha tenido usted problemas legales o fue arrestado a lo largo de su vida?				
0 = Nunca 1 = Raramente 2 = A veces 3 = Frecuentemente 4 = Muy frecuentemente				
SCORE positivo mayor o igual a 4				



Anexo 7 - Escala de Karnofsky³⁶⁻³⁷

Escala de Karnofsky	
Puntuación	Situación clínico – funcional
100	Normal, sin quejas ni evidencia de enfermedad.
90	Capaz de llevar a cabo actividad normal, pero con signos o síntomas leves.
80	Actividad normal con esfuerzo, algunos signos y síntomas de enfermedad.
70	Capaz de cuidarse, pero incapaz de llevar a cabo actividad normal o trabajo activo.
60	Requiere atención ocasional, pero es capaz de satisfacer la mayoría de sus necesidades.
50	Necesita ayuda importante y asistencia médica frecuente.
40	Incapaz, necesita ayuda y asistencia especiales.
30	Totalmente incapaz, necesita hospitalización y tratamiento de soporte activo.
20	Muy gravemente enfermo, necesita tratamiento activo.
10	Moribundo irreversible.
0	Muerto.

Anexo 8 - ECOG- PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status)³⁸

ECOG 0	El paciente se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar un trabajo y actividades normales de la vida diaria
---------------	---

ECOG 1	El paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque se desempeña normalmente en sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros. El paciente sólo permanece en la cama durante las horas de sueño nocturno
ECOG 2	El paciente no es capaz de desempeñar ningún trabajo, se encuentra con síntomas que le obligan a permanecer en la cama durante varias horas al día, además de las de la noche, pero que no superan el 50% del día. El individuo satisface la mayoría de sus necesidades personales solo.
ECOG 3	El paciente necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de síntomas. Necesita ayuda para la mayoría de las actividades de la vida diaria como por ejemplo el vestirse
ECOG 4	El paciente permanece encamado el 100% del día y necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria, como por ejemplo la higiene corporal, la movilización en la cama e incluso la alimentación.
ECOG 5	Paciente fallecido

Anexo 9 – Índice de Barthel (Actividades Básicas de la Vida Diaria-ABVD)³⁹

Actividad	Descripción	Puntuación
Comer	1. Dependiente	0
	2. Necesita ayuda para cortar, extender mantequilla, usar condimentos, etc.	5
	3. Independiente (capaz de usar cualquier instrumento)	10
Trasladarse entre la silla y la cama	1. Dependiente, no se mantiene sentado	0
	2. Necesita ayuda importante (1 persona entrenada o 2 personas), puede estar sentado	5
	3. Necesita algo de ayuda (una pequeña ayuda física o ayuda verbal)	10
	4. Independiente	15
Aseo personal	1. Dependiente	0
	2. Independiente para lavarse la cara, las manos y los dientes, peinarse y afeitarse	5
Uso del retrete	1. Dependiente	0
	2. Necesita alguna ayuda, pero puede hacer algo solo	5
	3. Independiente (entrar y salir, limpiarse y vestirse)	10
Bañarse o ducharse	1. Dependiente	0
	2. Independiente para bañarse o ducharse	5
Desplazarse	1. Inmóvil	0
	2. Independiente en silla de ruedas en 50 m	5
	3. Anda con pequeña ayuda de una persona (física o verbal)	10
	4. Independiente al menos 50 m, con cualquier tipo de muleta, excepto andador	15
Subir y bajar escaleras	1. Dependiente	0

	2. Necesita ayuda física o verbal, puede llevar cualquier tipo de muleta	5
	3. Independiente para subir y bajar	10
Vestirse y desvestirse	1. Dependiente	0
	2. Necesita ayuda, pero puede hacer la mitad aproximadamente, sin ayuda	5
	3. Independiente, incluyendo botones, cremalleras, cordones, etc.	10
Control de heces	1. Incontinente (o necesita que le suministren enema)	0
	2. Accidente excepcional (uno/semana)	5
	3. Continente	10
Control de orina	1. Incontinente, o sondado incapaz de cambiarse la bolsa	0
	2. Accidente excepcional (máximo uno/24 horas)	5
	3. Continente, durante al menos 7 días	10

INTERPRETACIÓN ÍNDICE DE BARTHEL

Puntuación	Clasificación
<20	Dependencia total
21 – 60	Dependencia severa
61 – 90	Dependencia moderada
91 – 99	Dependencia leve
100	Independencia

Anexo 10 - FAST (Functional assessment staging tool)⁴⁰

Etapas	Características	Diagnóstico clínico
1	Sin pérdida alguna de la funcionalidad	Normalidad
2	Déficit subjetivo para recordar nombres u otras palabras y/o déficit subjetivo para recordar la ubicación de objetos y/o disminución subjetiva de la capacidad para recordar turnos.	Deterioro cognitivo subjetivo.
3	Déficits observados en entornos laborales y sociales exigentes (p. ej., el individuo puede comenzar a olvidar reuniones importantes por primera vez; la productividad del trabajo puede disminuir); se pueden notar problemas en viajar a lugares desconocidos (por ejemplo, puede perderse viajando en auto y/o transporte público a una “nueva” ubicación o lugar)	Compatible con demencia incipiente
4	Déficits en el desempeño de tareas complejas de la vida diaria (por ejemplo, pagar facturas; disminución de la capacidad para planificar y/o preparar una comida elaborada; disminución de la capacidad en la compra correcta de artículos de supermercado)	Demencia Leve
5	Desempeño deficiente en la elección de la vestimenta adecuada. Requiere asistencia para el funcionamiento independiente en la comunidad: el cónyuge u otro cuidador con frecuencia debe ayudar al individuo a elegir ropa apropiada para la ocasión y/o temporada (por ejemplo, el individuo usará ropa incongruente); en el transcurso de esta etapa algunos pacientes también pueden comenzar a olvidarse de bañarse regularmente (a menos que se le recuerde) y la capacidad de manejar se ve comprometida (por ejemplo, descuido en el manejo de un auto y violaciones de las normas de conducción)	Demencia Moderada
6a	Requiere asistencia física para vestirse correctamente. El cuidador debe proporcionar cada vez más ayuda para que el individuo se vista adecuadamente. (por ejemplo, ponerse la ropa en la secuencia adecuada, atarse los cordones, calzarse los pies correctamente, abotonarse y/o cerrarse el cierre de la ropa, ponerse remera, pantalón, pollera, etc., correctamente)	Demencia moderadamente severa
6b	Requiere asistencia para bañarse correctamente. La capacidad del paciente para adaptarse la	Demencia moderadamente severa

	temperatura del agua del baño disminuye; el paciente puede tener dificultad para entrar y salir del baño; puede haber problemas con lavarse correctamente y secarse por completo	
6c	Requiere asistencia con la mecánica de ir al baño. Pacientes en esta etapa pueden olvidar tirar de la cadena del inodoro y puede comenzar a limpiarse incorrectamente o con menos fastidio al ir al baño.	Demencia moderadamente severa
6d	Incontinencia urinaria: ocurre en ausencia de infección u otra patología del tracto genitourinario	Demencia moderadamente severa
6e	Incontinencia fecal: en ausencia de patología gastrointestinal	Demencia moderadamente severa
7a	Discurso limitado a unas 6 palabras en el transcurso del día. El habla del paciente es restringida a palabras sueltas o frases breves	Demencia grave
7b	Vocabulario ininteligible limitado generalmente a una sola palabra en el curso de un día	Demencia grave
7c	Pérdida de la capacidad de deambular de forma independiente.	Demencia grave
7d	Pérdida de la capacidad de sentarse de forma independiente.	Demencia grave
7e	Pérdida de la capacidad de sonreír	Demencia grave
7f	Pérdida de la capacidad de sostener la cabeza	Demencia grave

Anexo 11 – GDS (Global Deterioration Scale)⁴¹

Etapas	Características	Diagnóstico clínico
1	Sin deterioro cognitivo	Normalidad
2	Alteración cognitiva subjetiva. Los pacientes en esta fase se quejan de olvidar dónde han colocado objetos familiares y de olvidar nombres que antes conocían bien.	Deterioro cognitivo subjetivo.
3	Déficits de memoria o cognitivos sutiles, observables por terceros. El paciente puede demostrar una menor facilidad para recordar los nombres de las personas que le acaban de presentar. la disminución del rendimiento se manifiesta en situaciones laborales y sociales exigentes. los compañeros de trabajo se dan cuenta del desempeño relativamente bajo del paciente. Las dificultades para encontrar palabras y nombres pueden volverse evidentes para los íntimos. El paciente puede perder o extraviar un objeto de valor.	Compatible con demencia incipiente
4	Déficits claros en el examen clínico. Deterioro cognitivo moderado. Los pacientes muestran un conocimiento reducido de los eventos recientes en sus propias vidas y de los eventos actuales en el mundo que los rodea. Pueden mostrar un déficit en la memoria de su historia personal. la capacidad de viajar solo se reduce notablemente y pueden manifestarse dificultades con la gestión de las finanzas.	Demencia Leve
5	Deterioro cognitivo moderadamente grave. Dificultad en el recuerdo de detalles personales importantes. Por ejemplo, pueden tener dificultad para recordar o dar respuestas incorrectas cuando se les pregunta sobre su dirección, número de teléfono o nombres de miembros cercanos de la familia. Los pacientes están algo desorientados en tiempo o espacio. Pueden tener algunas dificultades para elegir la ropa adecuada y, en ocasiones, pueden vestirse de manera inadecuada	Demencia Moderada
6	Gran incapacidad para verbalizar episodios recientes de su vida. Deterioro cognitivo grave. Puede olvidar el nombre del cónyuge. En esta etapa se producen alteraciones conductuales y de personalidad, que incluyen: 1) comportamiento delirante 2) síntomas obsesivos 3) síntomas de ansiedad, agitación e incluso comportamiento violento previamente inexistente 4) abulia cognitiva	Demencia moderadamente severa

7	Pocas palabras inteligibles o incompetencia verbal. Deterioro cognitivo y motor muy grave.	Demencia grave
---	--	----------------

- Anexo 12- The GDS/FAST Staging System⁴²

	GDS (Global Deterioration Scale)	FAST (Functional Assessment Staging)	Grado clínico Alzheimer
1	Sin pérdida alguna.	Sin pérdida alguna.	Normalidad.
2	Alteración cognitiva subjetiva. Quejas de memoria o de otras funciones cognitivas.	Déficit subjetivo en evocación de palabras o localización de objetos.	Deterioro cognitivo subjetivo.
3	Déficits de memoria o cognitivos sutiles, observables por terceros.	Déficits percibidos en contextos demandantes (ej. trabajo).	Deterioro cognitivo leve.
4	Déficits claros en el examen clínico. Deterioro cognitivo moderado.	Asistencia en tareas complejas, como la gestión de finanzas o planificar una comida de una celebración.	Demencia leve.
5	Deterioro cognitivo moderadamente grave. Dificultad en el recuerdo de detalles personales importantes.	Asistencia en la elección apropiada de la ropa.	Demencia moderada.
6	Gran incapacidad para verbalizar episodios recientes de su vida. Puede olvidar el nombre del cónyuge. Frecuentes alteraciones conductuales. Deterioro cognitivo grave.	FAST 6 a: Asistencia para vestirse. FAST 6 b: Asistencia para ducharse. FAST 6 c: Asistencia para el uso adecuado del baño (tirar la cadena, limpiarse...) FAST 6 d: Incontinencia urinaria. FAST 6 e: Incontinencia fecal.	Demencia moderadamente grave.
7	Pocas palabras inteligibles o incompetencia verbal. Deterioro cognitivo y motor muy grave.	FAST 7 a: Habla limitada a una media docena de palabras. FAST 7 b: Habla inteligible limitada a una palabra.	Demencia grave.

	FAST 7 c: Pérdida de la capacidad de andar.	
	FAST 7 d: Pérdida de la capacidad de mantenerse sentado.	
	FAST 7 e: Pérdida de la capacidad de sonreír.	
	FAST 7f: Pérdida de la capacidad de sostener la cabeza.	

Anexo 13– MDAS (Memorial Delirium Assessment Scale)⁴³

Escala de Valoración del Delirium del Memorial (MDAS)

INSTRUCCIONES: *Valore el grado de severidad de los siguientes síntomas de delirium basándose en la relación actual con el sujeto o valoración de su conducta o experiencia en las últimas horas (tal y como se indica en cada ítem).*

ÍTEM 1-DISMINUCIÓN DEL NIVEL DE CONCIENCIA. *Valore el nivel de conciencia actual del paciente respecto a su interacción con el entorno (entrevistador, otras personas u objetos en la habitación; por ejemplo, pida a los pacientes que describan lo que hay a su alrededor).*

☐ **0: No** (el paciente *de forma espontánea* es totalmente consciente del entorno e interactúa correctamente)

☐ **1: Leve** (el paciente no reconoce algunos elementos de su entorno o no interactúa correcta y espontáneamente con el entrevistador, pero *llega a estar totalmente consciente cuando se le insiste*; la entrevista se prolonga, pero no se deteriora significativamente)

☐ **2: Moderada** (el paciente no reconoce algunos o todos los elementos de su entorno o no interactúa espontáneamente con el entrevistador; está consciente de forma incompleta y *no llega a interactuar correctamente, aunque se insista*; la entrevista se prolonga, pero no se deteriora significativamente)

☐ **3: Grave** (el paciente *no reconoce* los elementos del entorno, *no es consciente* de la presencia del entrevistador, *ni existe interacción espontánea*, de manera que la entrevista se hace difícil o imposible, aunque el entrevistador insista continuamente)

ÍTEM 2-DESORIENTACIÓN: *Valore el estado actual preguntando los siguientes 10 ítems sobre orientación: día de la semana, día del mes, mes, año, estación, piso o planta, nombre del hospital, ciudad, comunidad autónoma y país*

☐ **0: No** (el paciente responde correctamente 9-10 ítems)

☐ **1: Leve** (el paciente responde correctamente 7-8 ítems)

☐ **2: Moderada** (el paciente responde correctamente 5-6 ítems)

☐ **3: Grave** (el paciente no responde correctamente más de 4 ítems)

ÍTEM 3-DETERIORO DE LA MEMORIA A CORTO PLAZO: Valore el estado actual pidiendo la *repetición inmediata de 3 palabras y la capacidad posterior para recordarlas* (el paciente debe repetir las palabras inmediatamente y recordarlas a los 5 minutos de haber estado realizando una tarea). Utilice grupos de 3 palabras diferentes para evaluaciones sucesivas (por ejemplo, manzana, mesa, mañana, cielo, cigarro, justicia).

☐ **0: No** (el paciente repite y recuerda las 3 palabras)

☐ **1: Leve** (el paciente repite las 3 palabras, pero no recuerda una de ellas)

☐ **2: Moderada** (el paciente repite las 3 palabras, pero no recuerda 2 o 3)

☐ **3: Grave** (el paciente no logra repetir 1 o más palabras)

ÍTEM 4-DETERIORO EN LAS SERIES NUMÉRICAS: Evalúe la capacidad actual del paciente, pidiéndole que repita, *primero 3, 4, 5 números contando hacia delante, y después 3 y 4 números contando hacia atrás*; continúe con el paso siguiente *sólo si el paciente realiza correctamente el anterior*.

☐ **0: No** (el paciente puede contar como mínimo 5 números hacia adelante y 4 hacia atrás)

☐ **1: Leve** (el paciente puede contar como mínimo 5 números hacia adelante, 3 hacia atrás)

☐ **2: Moderada** (el paciente puede contar 4-5 números hacia adelante, no puede contar 3 hacia atrás)

☐ **3: Grave** (el paciente no puede contar más de 3 números hacia adelante)

ÍTEM 5-DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE MANTENER LA ATENCIÓN Y DE CAMBIAR EL FOCO DE ATENCIÓN: *Manifestada durante la entrevista a través de las preguntas que necesitan ser reformuladas y/o repetidas debido a las pérdidas de atención del paciente, a la pérdida del hilo de la conversación por el enfermo o a las distracciones por estímulos externos o por estar absorto en otra tarea.*

☐ **0: No** (nada de lo mencionado anteriormente; el paciente mantiene y cambia la atención de forma totalmente normal)

☐ **1: Leve** (los problemas de atención descritos suceden *una o dos veces* sin prolongar la entrevista)

☐ **2: Moderado** (los problemas de atención descritos *son frecuentes, prolongando la entrevista, pero sin imposibilitarla*)

☐ **3: Grave** (los problemas de atención descritos *ocurren constantemente, alterando la entrevista y haciéndola difícil o imposible*)

ÍTEM 6–PENSAMIENTO DESORGANIZADO: Manifestado durante la entrevista por *divagaciones, un discurso irrelevante o incoherente, o por un razonamiento imperfecto o desordenado*. Formular al paciente alguna *pregunta compleja* (por ejemplo, pedirle que describa su situación clínica).

☐ **0: No** (el discurso del paciente es *coherente y bien dirigido*)

☐ **1: Leve** (el discurso del paciente es *ligeramente difícil de seguir*; las respuestas a las preguntas se alejan un poco del objetivo, pero no tanto como para prolongar la entrevista)

☐ **2: Moderado** (el discurso o pensamiento *desorganizado* está claramente presente, de modo que *la entrevista se prolonga, aunque no llega a ser interrumpida*)

☐ **3: Grave** (la entrevista es *muy difícil o imposible* debido al *discurso o pensamiento desorganizado*)

ÍTEM 7-ALTERACIONES DE LA PERCEPCIÓN: Valore las *percepciones erróneas, ilusiones, alucinaciones* deducidas de una *conducta inapropiada* durante la entrevista o *admitidas por el propio sujeto*, así como aquellas referidas por los *familiares, la enfermera* o descritas en la *historia clínica* en las últimas horas o desde la última valoración.

☐ **0: No** (*no existen* percepciones erróneas, ilusiones ni alucinaciones)

☐ **1: Leve** (percepciones erróneas o ilusiones relacionadas con el *sueño*, alucinaciones *fugaces* en 1 o 2 ocasiones *sin conducta inapropiada*)

☐ **2: Moderado** (alucinaciones o *frecuentes* ilusiones en *varias ocasiones* con *alteraciones mínimas del comportamiento que no interrumpen la entrevista*)

☐ **3: Grave** (ilusiones o alucinaciones *frecuentes o intensas* con *conductas persistentemente inadecuadas que interrumpen la entrevista o interfieren con los cuidados médicos*)

ÍTEM 8-IDEACIÓN DELIRANTE: Evalúe la *ideación delirante* inferida por la presencia de *conductas inadecuadas* durante la entrevista, *admitidas por el paciente*, así como la ideación delirante referida por los *familiares*, la *enfermera*, o descritas en la *historia clínica* en las últimas horas o desde la última valoración.

☐ **0: No** (no hay evidencia de interpretaciones erróneas ni de ideación delirante)

☐ **1: Leve** (*interpretaciones erróneas o suspicaces* sin ideación delirante manifiesta ni conducta inapropiada)

☐ **2: Moderada** (Ideación delirante *admitida por el paciente* o *evidenciada por su conducta*, que no interrumpen o *interrumpen de forma tangencial* la entrevista, y *no interfieren* con los *cuidados médicos*)

☐ **3: Grave** (Ideación delirante intensas y/o persistente que llevan a una *conducta inapropiada*, *interrumpiendo la entrevista* o *interfiriendo seriamente con el cuidado médico*)

ÍTEM 9-DISMINUCIÓN O AUMENTO DE LA ACTIVIDAD PSICOMOTORA: Valore la actividad en las últimas horas, así como la actividad durante la entrevista *categorizando al paciente*. Marque con un círculo: (a) *hipoactivo*, (b) *hiperactivo*, o (c) *ambos elementos presentes*.

☐ **0: No** (actividad psicomotora normal)

☐ **a b c 1: Leve** (la hipoactividad es apenas perceptible, expresada como *ligera reducción del movimiento*. La hiperactividad es apenas perceptible o se presenta como *simple inquietud*)

☐ **a b c 2: Moderado** (la hipoactividad es innegable, con *marcada reducción en el número de movimientos* o *marcada lentitud del movimiento*; el paciente raramente habla o se mueve espontáneamente. La hiperactividad es innegable, el paciente *se mueve casi constantemente*; en ambos casos, el examen clínico se prolonga como consecuencia)

☐ **a b c 3: Grave** (la hipoactividad es grave; el paciente *no se mueve o habla sin que se insista* o *está catatónico*. La hiperactividad es grave; el paciente *está constantemente moviéndose*, *reacciona exageradamente ante estímulos*, *requiere vigilancia y/o restricciones físicas*; realizar el examen clínico es difícil o imposible)

ÍTEM 10-ALTERACIÓN DEL CICLO VIGILIA-SUEÑO (TRASTORNO DEL DESPERTAR): Valore la capacidad del paciente para *dormirse* o *mantenerse despierto en los momentos apropiados*. Utilice la *observación directa* durante la entrevista, así como los *informes de enfermería*, la *familia*, el *paciente* o *gráficas* que describan el trastorno del ciclo vigilia-sueño durante las últimas horas o desde la última entrevista. Utilizar las observaciones de la noche previa sólo para las evaluaciones matutinas.

☐ **0: No** (duerme bien durante la noche; no tiene problemas para permanecer despierto durante el día)

□ **1: Leve** (leve alteración en los estados de sueño y vigilia; *durante la noche resulta difícil conciliar el sueño o existen despertares nocturnos transitorios, necesita medicación para dormir bien; durante el día, refiere periodos de somnolencia o, durante la entrevista está somnoliento, pero puede despertarse fácilmente*)

□ **2: Moderado** (alteración moderada en los estados de sueño y vigilia; *durante la noche hay repetidos y prolongados despertares; durante el día, refiere sueños frecuentes y prolongados o, durante la entrevista, puede sólo ser despertado completamente mediante fuertes estímulos*)

□ **3: Grave** (alteraciones graves en los estados de sueño y vigilia; *durante la noche permanece despierto; durante el día, el paciente permanece la mayor parte del tiempo durmiendo o, durante la entrevista, no puede ser despertado completamente mediante ningún estímulo*)

PUNTUACIÓN: ____.

Anexo 14 – CAM (Confusion Assessment Method)⁴⁴**Criterio 1: Inicio agudo y curso fluctuante**

Información sobre este criterio generalmente se obtiene de un miembro de la familia o profesional de enfermería. Considerar que se cumple si alguna de las respuestas a las siguientes preguntas es “sí”: ¿Existe evidencia de un cambio agudo en el estado mental en relación con el estado basal? ¿El comportamiento (anormal) fluctúa durante el día, es decir, tiende a ir y venir, o aumenta y disminuye en severidad?

Criterio 2: Inatención

Considerar que se cumple si la respuesta a la siguiente pregunta es “sí”: ¿Tuvo el paciente dificultad para centrar la atención, por ejemplo, se distraía con facilidad o tenía dificultad para seguir lo que se decía?

Criterio 3: Pensamiento desorganizado

Considerar que se cumple si la respuesta a la siguiente pregunta es “sí”: ¿El pensamiento del paciente estaba desorganizado o incoherente, observado en conversaciones incoherentes o irrelevantes, flujo de ideas poco claro o ilógico, o cambios impredecibles de sujeto a sujeto?

Criterio 4: Nivel de conciencia alterado

Considerar que se cumple si hay una respuesta diferente a “alerta” a la siguiente pregunta: En general, ¿cómo calificaría el nivel de conciencia del paciente? (alerta [normal], vigilante [hiperalerta], letárgico [somnoliento, se despierta fácilmente], estupor [difícil de despertar], o coma [no se puede despertar]). RASS diferente a 0 (entre +4 y -3)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Declaración de Astana. 2028. © World Health Organization and the United Nations Children's Fund (UNICEF), 2018.

2. World Health Organization. WHO definitions of palliative care. Disponible en: <http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/> (accesomarzo 2007).

3. Radbruch L, De Lima L, Knäul F. Redefining Palliative Care-A New Consensus-Based Definition. J Pain Symptom Manage. 2020;60(4):754-764.

4. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.

5. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.

6. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.

7. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.

8. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.

9. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.

10. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care>.
11. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.
12. Estrategias de cooperación OMS. Argentina- Observatorio Mundial de la Salud, Mayo de 2017. file:///C:/Users/gabri/Downloads/ccsbrief_arg_en.pdf.
13. Modelo de Atención Oncológica Integral según el *National Cancer Institute*. Adaptada de: *National Cancer Institute. EPEC™-O | Education in palliative and end-of-life care for oncology*. Disponible en: https://www.researchgate.net/figure/Figura-22-Modelo-de-Atencion-Oncologica-Integral-segun-el-National-Cancer-Institute_fig9_280158223.
14. Xavier Gómez-Batiste, Marisa Martínez-Muñoz, Carles Blay, (2012). *Identificación y Atención Integral-Integrada de Personas con Enfermedades Crónicas Avanzadas en Servicios de Salud y Sociales*.
http://ico.gencat.cat/web/.content/minisite/ico/professionals/documents/qualy/arxiu/doc_necpal_ccoms-ico_instrumento_doc_generalv1_esp_vf_201203.pdf.
15. Gómez-Batiste, X., Amblàs, J., Turrillas, P., Tebé, C., Peñafiel, J., Calsina, A., Costa, X., Vilaseca, J. M. y Montoliu, R. M. (2021). Recomendaciones prácticas para la identificación y la aproximación pronóstica de personas con enfermedades crónicas avanzadas y necesidades paliativas en servicios de salud y sociales. NECPAL 4.0 Pronóstico.
16. Fachado AA, Martínez NS, Roselló MM, Rial JJV, Oliver EB, García RG, García JMF (2018). Spanish adaptation and validation of the Supportive & Palliative Care Indicators Tool – SPICT-ESTM. *Rev Saude Publica*; 52: 3.
17. Wenk, R. (2015). Manual de Cuidados Paliativos. Fundación Femeba (p.7).
18. Wenk, R. (2015). Manual de Cuidados Paliativos. Fundación Femeba (p.7).
19. Von Günten CF. Secondary and tertiary palliative care in US Hospitals. *JAMA*. 2002;287:875-81.
20. Benítez del Rosario MA, Salinas A, Serrano PG. Organización integral de los cuidados paliativos: hacia un modelo de atención compartida. En: Benítez MA, Salinas A, editores. *Cuidados paliativos y atención primaria. Aspectos de organización*. Barcelona: Springer; 2000. p. 119-33.
21. Herrera E, Villegas R. Evolucionando hacia la Atención Domiciliaria. *Medicina de Familia (And)*. 2000; 2:169-73.
22. Herrera Molina E, Gil J, Cuervo Pinnay MA. Primer nivel asistencial en cuidados paliativos: evolución del contenido de la cartera de servicios de atención primaria y criterios de derivación al nivel de soporte. *Aten Primaria*. 2006;38(Supl 2):85-92. Disponible en: <http://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-articulo-primer-nivel-asistencial-cuidados-paliativos-13094780>.
23. Martín-Roselló, M. L. et al. (2014). IDC-PAL: instrumento diagnóstico de la complejidad en cuidados paliativos: documento de apoyo al PAI cuidados paliativos. Disponible en: <https://www.redpal.es/wp-content/uploads/2018/12/IDC-Pal-2014-Complejidad.pdf>.
24. Busquet-Duran, X.2, Jiménez-Zafra, E.1 Tura-Poma, M
Hexágono de la complejidad (*HexCom-Clin*) ©2018
Programa d'Atenció Domiciliària. Equip de Suport (PADES) Granollers. Servei d'Atenció Primària Vallès Oriental. Institut Català de la Salut. Granollers. Barcelona. *Equip d'Atenció Psicosocial (EAPS) Creu Roja. Granollers. Barcelona. ** Equip d'Atenció Psicosocial (EAPS) Mutuam Girona.
25. Chapman, C.R. y Gravin, J. (1993) Suffering and its relationship to pain. *Journal of Palliative Care*, 9(2), 5-13.

26. Krikorian A, Limonero J. Factores asociados a la experiencia de sufrimiento en pacientes con cáncer Avanzado. *Av. Psicol. Latinoamericana* 2015;vol.33.
27. Jairo, María Clara Vélez y Alicia Krikorian. (2008). Aspectos Neurobiológicos, psicológicos y sociales del sufrimiento. *Psicooncología*. Vol. 5, Núm. 2-3, 2008, pp. 245-255.
28. Ferris FD, Balfour HM, Bowen K et al. A model to guide patient and family care: based on nationally accepted principles and norms of practice. *J Pain Symptom Manage* 2002; 24: 106-123.
29. Quill TE, Abernathy AP. Generalist plus specialist palliative care-creating a more sustainable model. *N Engl J Med* 2013; 368: 1173.
30. <https://www.tmcaz.com/assets/documents/painclinic/cage-english-espanol.pdf>.
31. Butler SF, Fernandez K, Benoit C, Budman SH, Jamison RN. Validation of the revised Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP-R). *J Pain* 2008;9:360–72.
32. Inflexxion. Screener and Opioid Assessment for Patients with Pain (SOAPP) version 1.0 SF. 2008; painedu@inflexxion.com.
33. Hui D, Bruera E. A personalized approach to assessing and managing pain in patients with cancer. *J Clin Oncol*. 2014 Jun 1;32(16):1640-6. doi: 10.1200/JCO.2013.52.2508. Epub 2014 May 5. PMID: 24799495; PMCID: PMC4031188.
34. Carvajal et al. Versión española del Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): un instrumento de referencia para la valoración sintomática del paciente con cáncer avanzado. *Medicina Paliativa*. 2013;20(4):143-9.
35. Galiana et al. (2014). Recursos en evaluación y acompañamiento espiritual- Revisión de medidas y presentación del cuestionario GES. En: Benito et al. (Eds.) *Espiritualidad en clínica* (pp. 131-145). Madrid: SECPAL.
36. Karnofsky DA, Burchenal JH. The Clinical Evaluation of Chemotherapeutic Agents in Cancer. In: MacLeod CM (Ed), *Evaluation of Chemotherapeutic Agents*. Columbia Univ Press. 1949, Page 196.
37. Schag CC, Heinrich RL, Ganz PA. Karnofsky performance status revisited: Reliability, validity and guidelines. *J Clin Oncology* 1984; 2:187-193.
38. Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status (ECOG PS) adoptado por la Organización Mundial de la Salud. Oken et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Clin Oncol*. 1982;5(6):649-55.
39. Cech, D. J., Martin, S.T. Chapter 5-evaluation of function, activity, and participation. En: Cech DJ, Martin ST (eds) *Functional movement development across the life span*, 3rd edn. 2012. W.B. Saunders, Saint Louis, pp 88–104.
40. [Sclan](#) S, [Reisberg](#) B. Functional Assessment Staging (FAST) in Alzheimer's Disease: Reliability, Validity, and Ordinality. *International Psychogeriatrics* 1992; 4 (3):55 – 69.
41. Reisberg B, Ferris SH, de Leon M. J. The Global Deterioration Scale for assessment of primary degenerative dementia. *The American Journal of Psychiatry* 1982;139(9):1136–1139.
- 42. Auer S, Reisberg B. The GDS/FAST Staging System. *International Psychogeriatrics* 1997; 9 (S1):167 – 171.
43. [Lawlor](#) P, [Nekolaichuk](#) C, [Gagnon](#) B. Clinical utility, factor analysis, and further validation of the memorial delirium assessment scale in patients with advanced cancer: Assessing delirium in advanced cancer. *Cancer* 2000 Jun 15;88(12):2859-67.

44. Inouye SK, van Dyck CH, Alessi CA. Clarifying confusion: the confusion assessment method. A new method for detecting delirium. *Ann Intern Med* 1990; 113: 941–948.

*primero
la gente*



argentina.gob.ar/salud/inc